REPUBLIQUE DU CONGO

Unité - Travail - Progrès

MINISTERE DE LA SANTE ET DE
LA POPULATION

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

PROGRAMME NATIONAL DE
LUTTE CONTRE
L'INSUFFISANCE RENALE



PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE 2025 -2029

TABLE DE MATIERES

REMERCIEMENTS 4
SIGLES ET ACRONYMES 5
DEFINITION DES CONCEPTS 7
PREFACE 9
. 9
LISTE DES TABLEAUX 10
LISTE DES FIGURES 11
RESUME DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL (PSN) 12
INTRODUCTION 14
PREMIERE PARTIE : PROFIL DU PAYS 16
I.1 Présentation du pays 16
I.1.1 Situation géographique 16
I.1.2 Situation démographique 16
I.1.3 Situation économique 17
I.1.4 Organisation politique et administrative 18
I.2 Système de santé 19
I.2.1 Organisation du système de santé 19
I.2.1.1 Organisation administratif 20
I.2.1.2 Organisation de l'offre des soins et services de santé 21
I.2.1.3 Déterminants socio-sanitaires 23
I.3 Situation épidémiologique de l'insuffisance rénale 24
I.3.1 Situation mondiale de l'insuffisance rénale et des maladies rénales 24
I.3.2 Situation de l'insuffisance rénale en Afrique 26
I.3.3 Situation de l'insuffisance rénale au niveau national 26
II. DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE 33
II.1 La Direction du programme 33
II.2 Le Comité Scientifique du PNLIR 34
III. TROISIEME PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE ET IDENTIFICATION DES PROBLEMES PRIORITAIRES 35
III.1 Analyse de la situation 35
III.2 Identification des problèmes prioritaires 40
IV. QUATRIEME PARTIE : STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE AU CONGO 44
IV.1 But et Vision 44

IV.1.1 Vision 44
IV.1.2 But 44
IV.1.3 Objectifs 44
IV.2 Orientations Stratégiques 47
V. Cadre logique 49
VI. Plan de financement 65
VII. Cadre de mise en œuvre 77
VII.1 Niveau central 77
VII.2 Niveau intermédiaire 77
VII.3 Niveau périphérique 77
VIII. Cadre de suivi et évaluation 78
IX. Indicateurs de suivi et d'évaluation 79
X. Facteurs de risque, de succès (éléments de pérennité du plan) 81
X.1 Risques d'échec 81
X.1 Facteur de succès 81
CONCLUSION 82
Références 83
Annexe 84

REMERCIEMENTS

Le Plan Stratégique National (PSN) 2025 – 2029 de lutte contre l'insuffisance rénale est le fruit de l'engagement des acteurs, décideurs et partenaires impliqués dans la lutte contre l'insuffisance rénale au Congo. Il s'appuie sur les orientations de la Politique Nationale de Santé (PNS), du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) et des Directives de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il a été élaboré à l'issue d'un consensus national fait sur une analyse situationnelle, en prenant en compte les priorités nationales en matière de lutte contre l'insuffisance rénale. L'élaboration et la validation de ce plan ont été rendues possibles grâce aux subventions de l'État, ainsi qu'au soutien technique et financier de l'OMS et du laboratoire Roche. Leur contribution a permis de mobiliser des ressources essentielles pour renforcer les groupes de travail sur diverses thématiques.

À cet effet, nous exprimons notre profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers, aux donateurs, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre l'insuffisance rénale. Leur appui multiforme, d'une valeur inestimable, a permis de soutenir efficacement les différentes équipes de travail, dont l'expertise, l'engagement et les contributions pertinentes ont été déterminants dans l'élaboration de ce document.

Que toutes les institutions et structures qui n'ont pas été citées de manière singulière et les personnes-ressources qui ont contribué par leur engagement et leur professionnalisme à l'élaboration et à la validation de ce Plan Stratégique National, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

SIGLES ET ACRONYMES

AFR/RC	Comité Régional de l'OMS pour l'Afrique
APD	Aide Publique au Development
ARV	Antirétroviraux
CAMEPS	Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et produits de Santé
CAP	Connaissances, Attitude et Pratiques
CD	Centre de Dialyse
CH	Centre d'Hémodialyse
CHEMUR	Centre d'hémodialyse Urbain
COGES	Comité de gestion
COSA	Comité de Santé
CSI	Centre de Santé Intégré
DDSSSa	Direction Départementale des Soins et Services de Santé
DGAR	Direction Générale de l'Administration et des Ressources
DGPOP	Direction Générale de la Population
DGSSSa	Direction Générale des Soins et Services de Santé
DISER	Direction de l'Information Sanitaire, de l'Evaluation de la Recherche
DS	District Sanitaire
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
DSS	Déterminants Sociaux de la Santé
ECOM	Enquête Congolaise des Ménages
EDSC	Enquête Démographique et de Santé du Congo
EPO	Erythropoeitine
EPS	Education pour la Santé
FOSA	Formation Sanitaire
HTA	Hypertension Artérielle
IDH	Indice de Développement Humain
IEC	Information, Education et Communication
IR	Insuffisance rénale
IRA	Insuffisance rénale aigue
IRC	Insuffisance rénale chronique
IRCT	Insuffisance rénale chronique terminale
IST	Infection Sexuellement Transmissible
MRC	Maladie rénale chronique

MSP	Ministère de la Santé et de la Population
ODD	Objectifs de Développement Durable
OIT	Organisation Internationale du Travail
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PEV	Programme élargi de vaccination
PIB	Produit Intérieur Brut
PIC	Plan intégré de communication
PMA	Paquet minimum d'activités
PMAE	Paquet minimum d'activités élargies
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PNGDBM	Politique Nationale de Gestion de Déchets Biomédicaux
PNPS	Politique Nationale de Promotion de la Santé
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE	Pays pauvre très endetté
PTF	Partenaire Technique et Financier
RCB	Registre du Cancer de Brazzaville
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'habitat
RSE	Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises
RSI	Règlement Sanitaire International (2005)
SCME	Société Congolaise de Maladie Endocrinologie
SIMR	Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte
SNIS	Système National d'Information Sanitaire
SONU	Soins obstétricaux et néonatals d'urgence
SONUC	Soins obstétricaux et néonatals d'urgence complets
TSR	Thérapie de suppléance rénale
UCPP	Unité de Coordination des Programmes et des Projets
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humain
VPH	Virus du papillome humain.
WHA	Assemblée Mondiale de la Santé

DEFINITION DES CONCEPTS

Sur la base d'une revue de la littérature, de l'expérience et du contexte, les concepts essentiels suivants sont retenus :

Capacité : ensemble des qualités et des ressources dont dispose une communauté en vue d'anticiper l'impact d'un danger, d'y faire face, d'y remédier et de s'en remettre.

Comorbidité : présence simultanée de deux ou plusieurs maladies chez une même personne, qu'elles soient liées entre elles ou non.

Facteurs de risque : tout attribut, caractéristique ou exposition d'un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie.

Hémodialyse : traitement médical qui permet de remplacer temporairement la fonction des reins lorsqu'ils ne sont plus capables d'assurer leur rôle à l'aide d'un filtre appelé **dialyseur**.

Incident : événement perturbateur ou obstacle destiné à perturber le cours d'une action.

Insuffisance rénale aiguë : détérioration brutale ou rapidement progressive, en moins de 3 mois, de la fonction rénale se traduisant par une élévation de la créatinine**.**

Insuffisance rénale chronique : détérioration progressive et irréversible de la fonction rénale, souvent dû à des maladies chroniques comme le diabète (cause principale), l'hypertension artérielle, les maladies rénales héréditaires et les infections rénales répétées.

Maladies non transmissibles : groupe de maladies qui ne sont pas causées par des agents infectieux et qui ne se transmettent pas d'une personne à l'autre.

Maladie rénale chronique : atteinte rénale se traduisant par la positivité d'au moins un marqueur rénal depuis au moins trois (3) mois (protéinurie, hématurie, créatinine) ou une maladie longtemps silencieuse, d'évolution progressive et sans possibilité de guérison.

Planification : processus qui consiste à fixer des objectifs, à définir des stratégies et à organiser les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs dans un délai déterminé.

Populations à risque : ensemble des individus exposés à des facteurs cliniques, démographiques ou environnementaux susceptibles d'augmenter leur probabilité de développer une atteinte rénale aiguë ou chronique.

Prévention : ensemble de mesures permettant d'éviter complètement ou de réduire le nombre et les effets négatifs des maladies, des accidents et des handicaps.

Prise en charge : ensemble des actions et des moyens mis en œuvre pour accompagner, traiter ou assister une personne en fonction de ses besoins médicaux, psychologiques, sociaux ou éducatifs.

Prise en charge de l'insuffisance rénale : ensemble des actions, techniques et procédés destinés à traiter, soulager et accompagner les patients insuffisants rénaux.

Soins palliatifs : ensemble des soins d'accompagnement destinés aux personnes atteintes de

maladies graves, évolutives ou en phase terminale, dans le but d'améliorer la qualité de vie du patient tout au long de cette période.

VIH /sida : le virus de l'immunodéficience humaine est une espèce de rétrovirus infectant l'humain et responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), qui est un état affaibli du système immunitaire.

Vulnérabilité : conditions déterminées par des facteurs ou des processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui augmentent la sensibilité d'une communauté aux effets des dangers.

PREFACE



La problématique de l'insuffisance rénale constitue aujourd'hui un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale, en Afrique et particulièrement en République du Congo. En constante progression, cette maladie touche toutes les catégories de la population et entraîne une lourde charge de morbidité, de mortalité et de dépenses de santé. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 10 % de la population adulte mondiale est atteinte d'une maladie rénale chronique.

En Afrique subsaharienne, la maladie demeure également préoccupante, avec des prévalences élevées rapportées dans plusieurs pays, notamment en République démocratique du Congo (19 %), au Nigeria (17 %) et au Cameroun (14 %). La République du Congo n'échappe pas à cette tendance. Les données nationales montrent une fréquence élevée de l'insuffisance rénale, une mortalité encore importante et un accès limité aux traitements spécialisés, notamment à la dialyse.

Face à cette situation, le gouvernement de la République du Congo, à travers le Ministère de la Santé et de la Population et le Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale, avec l'appui de ses partenaires, a élaboré le Plan Stratégique National de lutte contre l'insuffisance rénale 2025-2029.

Ce premier Plan Stratégique National constitue le cadre de référence des interventions visant à renforcer la prévention, la promotion de la santé rénale, le dépistage précoce, la prise en charge des patients ainsi que le suivi-évaluation des actions entreprises. Il contribuera à l'atteinte de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, relative à la réduction de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles d'ici à 2030.

La réussite de ce plan repose sur l'engagement de l'ensemble des acteurs : pouvoirs publics, partenaires techniques et financiers, professionnels de santé, société civile, communautés et patients. J'invite chacun à s'approprier ce document stratégique et à contribuer activement à sa mise en œuvre afin d'améliorer durablement la santé rénale de nos populations.

Ministre de la Santé et de la Population

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE
REPUBLIQUE DU CONGO

Professeur Jean-Rosaire IBARA

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Répartition de la population générale par département en 2023..... 17

Tableau II : Structuration du territoire en départements, districts, communes et arrondissements. 18

Tableau III : Structuration du territoire en départements et districts sanitaires. 21

Tableau IV : Répartition des ressources humaines par catégorie pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique au stade de dialyse au Congo en 2021. 28

Tableau V: Présentation de l'analyse des FFOM sur le renforcement de la gouvernance, du leadership et pilotage du programme national de lutte contre l'insuffisance rénale 35

Tableau VI :Présentation de l'analyse des FFOM sur le renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR..... 36

Tableau VII : Présentation de l'analyse des FFOM sur la promotion de la sante rénale. 37

Tableau VIII : Présentation de l'analyse des FFOM sur la gestion de l'information sanitaire et la recherche sur l'insuffisance rénale 39

Tableau X : présentation de l'analyse des FFOM sur promotion de la santé rénale..... **Erreur ! Signet non défini.**

Tableau X : Présentation des objectifs et résultats attendus du PSN. 45

LISTE DES FIGURES

Figure 1:: Carte administrative du Congo. 16

Figure 2: Schéma de l'organisation du système de santé du Congo..... 19

Figure 3 : cartographie des centres d'hémodialyse en république du Congo. 28

RESUME DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL (PSN)

Le Plan Stratégique National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale 2025-2029 a été élaboré selon une approche participative et multidisciplinaire, impliquant les différentes parties prenantes et les cadres des structures sous tutelle du Ministère de la Santé et de la Population. Il définit les stratégies d'orientation traduites en termes de programmes et des domaines d'interventions pour un meilleur contrôle de la situation de lutte contre l'Insuffisance Rénale au Congo.

En effet, l'insuffisance rénale est un problème majeur de santé publique, avec une prévalence d'environ 10 % de la population générale mondiale. Certains facteurs expliquent l'augmentation du nombre des patients chaque année, tels la hausse des maladies chroniques (hypertension artérielle, diabète), l'accès limité aux soins et aux services de santé et le manque de sensibilisation de la population. Les infrastructures de santé sont souvent insuffisantes pour gérer efficacement les cas d'insuffisance rénale, ce qui entraîne des complications graves et un taux de mortalité élevé.

En s'alignant au PNDS, le Plan Stratégique National de lutte contre l'insuffisance rénale met l'accent sur l'amélioration des performances et la résilience du système de santé, garantissant à chaque personne souffrant de cette maladie un accès équitable aux soins et services de santé appropriés.

Dans le cadre de l'ODD3-4, qui est de réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles, dont l'insuffisance rénale à l'horizon 2030, un objectif stratégique a été défini pour atténuer l'effet et l'impact de l'insuffisance rénale sur la population générale et à risque. Il s'agit de : « Réduire de 75 % la morbidité et de 50 % la mortalité liée à l'insuffisance rénale par la prévention de la maladie, la promotion de la santé rénale et la prise en charge des patients d'ici à 2029 ».

Pour la mise en œuvre de ce plan, huit (8) objectifs spécifiques et dix-sept (17) résultats attendus sont définis et répartis dans les quatre (4) programmes ci-après :

- **Programme 1.** Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de la Lutte contre l'Insuffisance Rénale ;
- **Programme 2.** Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR ;
- **Programme 3.** Promotion de la santé rénale ;
- **Programme 4.** Gestion de l'information sanitaire et la recherche sur l'insuffisance rénale.

Les stratégies et interventions développées dans ce plan seront mises en œuvre durant cinq ans, pour un coût global prévisionnel de **1 457 540 400** FCFA. Un plan de suivi et évaluation a été défini pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce PSN.

INTRODUCTION

La transition épidémiologique observée dans les pays en développement, marquée par le passage progressif des maladies transmissibles vers une prédominance des maladies non transmissibles, constitue un déterminant majeur de l'augmentation de la charge des maladies chroniques, notamment l'insuffisance rénale. Cette transition est accentuée par l'urbanisation, le vieillissement progressif de la population et la croissance des facteurs de risque métaboliques et comportementaux.

Les maladies non transmissibles posent un sérieux problème de santé publique et sont responsables de 30 millions de décès dans le monde, dont 80 % surviennent dans les pays à revenu faible comme le Congo (1). Parmi ces maladies non transmissibles, figure l'insuffisance rénale notamment l'insuffisance rénale chronique. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'insuffisance rénale chronique est responsable de 5 millions de décès par an à travers le monde et reste la pathologie souvent négligée dans les systèmes de santé des pays de l'Afrique sub-saharienne (2).

En Afrique subsaharienne, caractérisée par une population majoritairement jeune, on note une augmentation annuelle du nombre de patients présentant une IR avec un âge moyen oscillant entre 30 et 60 ans. Les facteurs favorisants sont : la pauvreté et les comportements à risque. En conséquence, si l'on n'agit pas sur ces facteurs de risque dans les communautés et les pays lourdement affectés, son impact continuera de s'accroître, compromettant les objectifs du PSN et l'atteinte de l'ODD3-4 à l'horizon 2030.

En République du Congo, la situation de l'IR est préoccupante. En 2020, près de 52,1 % des patients admis au service de néphrologie du CHU de Brazzaville étaient affectés de l'insuffisance rénale chronique avec 3,87 % de forme aiguë et 49,9 % de décès. Pour faire face à cette situation, la Direction du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale a élaboré et validé avec l'appui des partenaires techniques et financiers (PTF) un Plan Stratégique National 2025-2029 de Lutte contre l'Insuffisance Rénale. Ce plan contient plusieurs interventions dont la mise en œuvre nécessite l'implication de divers secteurs ainsi qu'une volonté politique affirmée. Car la prise en charge de l'IRC notamment au stade de dialyse, pèse lourd pour le système de soins. Celle-ci ne peut se faire sans le renforcement préalable de ce système (plateau technique, matériel de travail, etc.). Il s'agit du déploiement d'unités d'hémodialyse au niveau des grandes agglomérations avec une accessibilité équitable pour

toutes les couches sociales, mais aussi de poser les bases d'unités de coordination de la transplantation rénale.

En outre, l'intégration du paquet des soins et services de prévention et de prise en charge, notamment de l'IR chronique dans les soins de santé primaires est cruciale pour atteindre toutes les cibles et mener une lutte efficace. Aussi, le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de santé du niveau intermédiaire et périphérique reste indispensable pour maximiser les possibilités d'intervention en vue de prévenir, détecter et prendre en charge l'IR et ses facteurs de risque. Mais aussi, de rééduquer, d'alléger les souffrances des patients et de dispenser des soins palliatifs.

Compte tenu de la gravité du problème, il est important d'investir des fonds suffisants et durables dans la lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier l'insuffisance rénale, afin de réduire ces multiples complications.

Le présent Plan Stratégique National 2025-2029 de lutte contre l'insuffisance rénale se décline en quatre parties, notamment : le profil du pays, la présentation du PNLIR, l'analyse de la situation de lutte contre l'IR et l'identification des problèmes prioritaires ainsi que la stratégie nationale de lutte contre l'IR.

PREMIERE PARTIE : PROFIL DU PAYS

I.1 Présentation du pays

I.1.1 Situation géographique

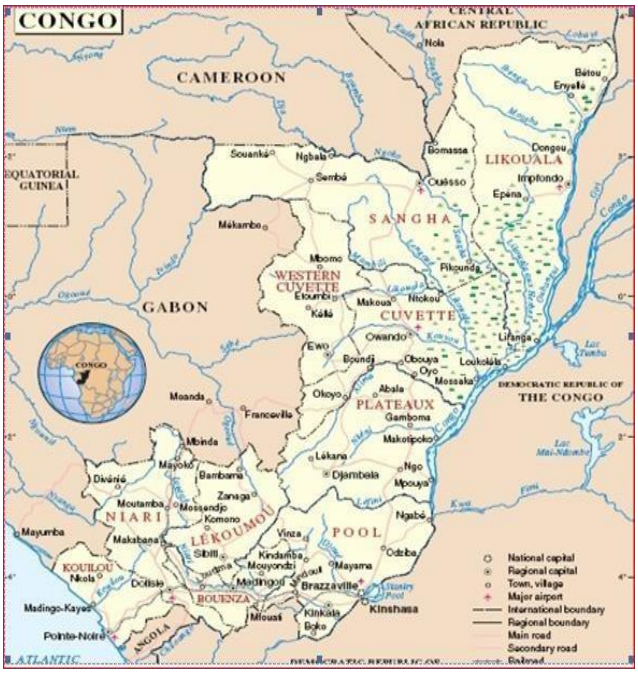


Figure 1: : Carte administrative du Congo.

La République du Congo est située au cœur de l'Afrique centrale et à cheval sur l'équateur, entre les latitudes 3°30 Nord et 5° Sud, et les longitudes 11° et 18° Est. Elle s'étend sur une superficie de 342.000 km² et partage ses frontières avec 5 pays : le Gabon à l'Ouest sur 1.903 km, le Cameroun au Nord-Ouest sur 523 km, l'Angola et l'enclave du Cabinda au Sud sur 201 km, la République Centrafricaine au Nord sur 467 km et la République Démocratique du Congo à l'Est sur 2.410 km le long du fleuve Congo et de la rivière Oubangui. La République du Congo est située dans la zone des climats chauds et humides. Au Nord, le climat est équatorial avec une forte pluviométrie, alors que dans le Sud-ouest, il est tropical et subtropical.

La température moyenne se situe autour de 25 °C. Le climat congolais se caractérise par une dominance des saisons de pluies qui durent 8 à 9 mois sur les saisons sèches observées pendant 3 à 4 mois. La richesse hydraulique fait du Congo l'un des pays les plus fertiles du continent africain, avec des forêts luxuriantes où l'on trouve encore plusieurs espèces de bois.

I.1.2 Situation démographique

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2023 a évalué la population résidente à 6.142.180 habitants avec un taux d'accroissement de 3,2 % et une prédominance des femmes à hauteur de 50.34 % contre 49.65 % d'hommes. La majeure partie de sa population est urbanisée (70 %). Les deux principales villes (Brazzaville et Pointe-Noire) représentent 58,1 %. La répartition par sexe selon les départements est représentée dans le Tableau I.

Tableau I : Répartition de la population générale par département en 2023.

Département	2023		
	Homme	Femme	Total
Kouilou	52 111	45 251	97 362
Niari	160 761	174 102	334 863
Lékoumou	50 313	50 246	100 559
Bouenza	180 914	182 936	363 850
Pool	197 707	196 825	394 532
Plateaux	137 918	145 503	283 421
Cuvette	153 648	162 951	316 599
Cuvette – Ouest	58 280	61 048	119 328
Sangha	113 359	96 342	209 701
Likouala	174 270	181 300	355 570
Brazzaville	1 061 708	1 084 075	2 145 783
Pointe-Noire	708 953	711 659	1 420 612
Total	**3 049 942**	**3 092 238**	**6 142 180**
%	**49,65**	**50,34**	**100**

(Source : INS 2023).

I.1.3 Situation économique

L'économie du Congo repose principalement sur le pétrole qui fournit 90 % des recettes de l'Etat. Cependant, pour la période 2022-2026, le Congo s'est engagé pour « une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible ». En attendant, l'activité économique s'est contractée en 2020, avec une croissance du PIB estimée à -6,2 %, en raison principalement de l'impact de la Covid-19 et de l'effondrement des prix mondiaux du pétrole. Le secteur agricole a connu une croissance lente et plus faible que prévu. Elle a été en moyenne annuelle de 1,6 % entre 2018-2020. Ce ralentissement économique a des conséquences sur le système éducatif du Congo, qui se caractérise par des taux bruts de scolarisation qui dépassent les 100 % (106,1 % au primaire en 2019-2020).

Cependant, l'enseignement primaire présente de faibles performances en termes d'acquis scolaires : 66,6 % des élèves n'atteignent pas le seuil « suffisant » en mathématiques et 21 % ne l'atteignent pas en français. L'accès aux services sociaux de base reste préoccupant. En 2019,

seulement 48 % de la population a eu accès à l'électricité et 68% à l'eau potable. Un quart de la population dispose de toilettes modernes privées. Les autres utilisent des installations sanitaires précaires.

I.1.4 Organisation politique et administrative :

L'organisation administrative est structurée en départements, communes, arrondissements, districts, communautés urbaines, communautés rurales, quartiers et villages. Le Congo compte : 12 départements, 90 districts, 16 communes, 43 communautés urbaines, 23 arrondissements, 90 communautés rurales, 609 quartiers et 3456 villages, comme indique le tableau II ci-après.

Tableau II : Structuration du territoire en départements, districts, communes et arrondissements.

N°	Départements	Districts	Communes	Arrondissements
1	Brazzaville	1	1	9
2	Pointe-Noire	1	1	6
3	Kouilou	6	0	0
4	Niari	14	2	4
5	Bouenza	10	2	2
6	Lékoumou	5	1	0
7	Pool	13	2	0
8	Plateaux	11	1	0
9	Cuvette	10	2	0
10	Cuvette-Ouest	6	1	0
11	Sangha	6	2	2
12	Likouala	7	1	0
Total		**90**	**16**	**23**

Selon les termes de la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales, les départements participent à l'établissement de la carte sanitaire nationale, élaborent et exécutent le plan d'urgence de santé et d'hygiène, gèrent les aides sociales aux personnes vulnérables, construisent ou acquièrent, équipent, entretiennent, gèrent

et assurent la maintenance des installations, des crèches, garderies d'enfants, postes de santé, centres de santé intégrés, centres de promotion et de réinsertion sociale.

I.2 Système de santé

I.2.1 Organisation du système de santé

Le système de santé au Congo est de type pyramidal à trois (3) niveaux et est organisé en un système (versant) administratif et un système sanitaire qui offre des soins et des services de santé.

La figure 1 ci-après schématise l'organisation du système de santé congolais.

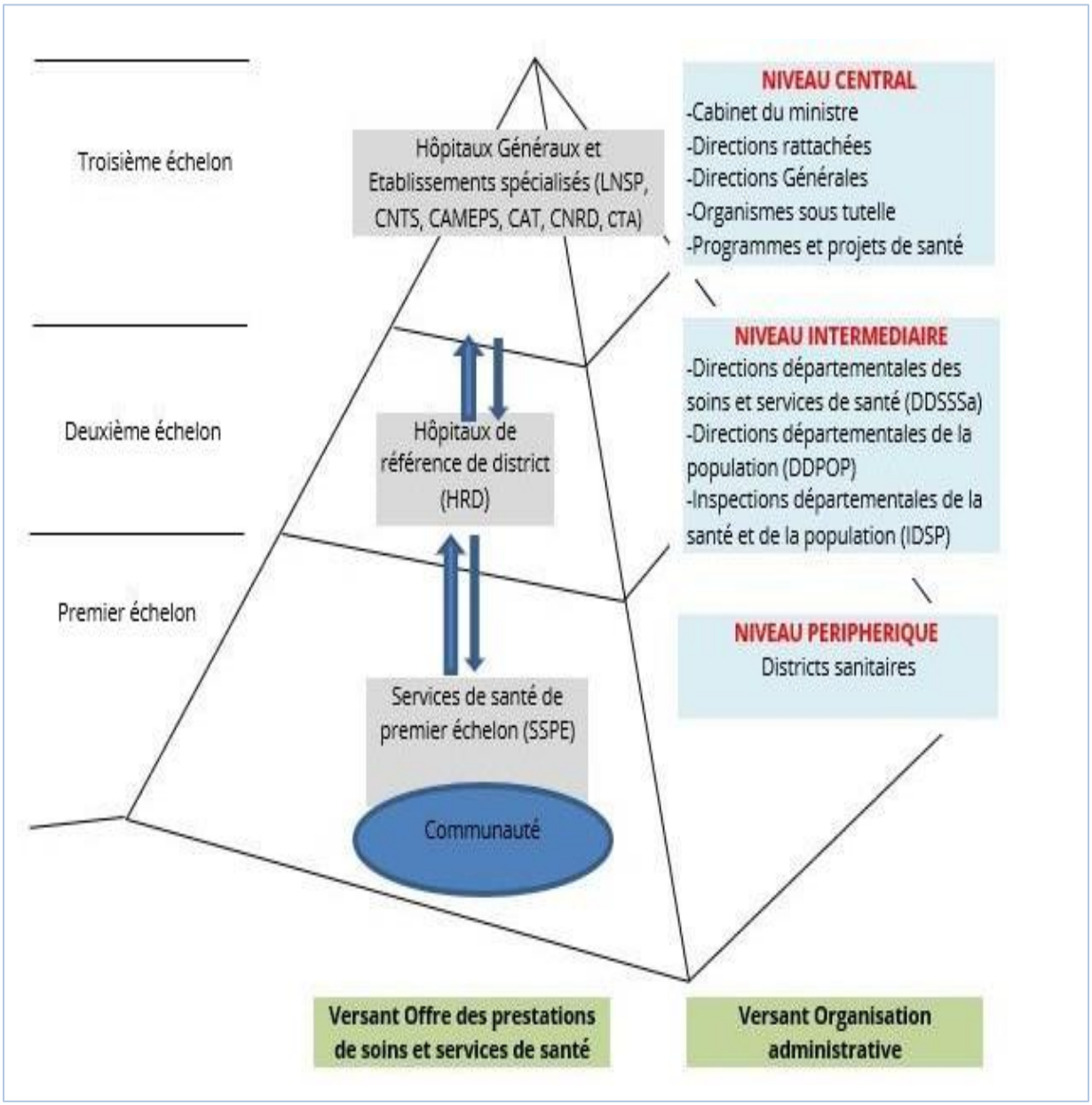


Figure 2: Schéma de l'organisation du système de santé du Congo.

I.2.1.1 Organisation administratif

Le Décret n°2018-268 du 02 juillet 2018 organise le Ministère de la Santé et de la Population en trois niveaux hiérarchiques : central, intermédiaire et opérationnel.

- **Niveau central**

Son rôle est stratégique et normatif dans la planification, le suivi, l'évaluation, la coordination, la mobilisation et l'allocation des ressources. Il est représenté par le cabinet du ministre en charge de la santé, l'inspection générale de la santé, les directions rattachées au cabinet, les directions générales. Le niveau central a pour mission de définir et conduire la politique de santé, de faire le suivi, l'évaluation et de piloter la recherche, la formation et la régulation. Il coordonne les appuis des partenaires techniques et financiers (PTF) et des donateurs. L'Unité de Coordination des Programmes et Projets (UCPP), rattachée au Cabinet du Ministre, assure la coordination de 14 programmes de santé, dont **le Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR).**

- **Niveau intermédiaire**

Le niveau intermédiaire est représenté par : (i) les 12 Directions Départementales des Soins et Services de Santé (DDSSSa), (ii) les 12 directions départementales de la population, (iii) les 03 inspections interdépartementales de la santé et de la population. Ces dernières jouent respectivement le rôle d'appui technique aux districts sanitaires. Les territoires des départements sanitaires obéissent au découpage administratif du pays.

- **Niveau périphérique**

Selon l'arrêté n°299 du 17 mars 2026, le Congo est découpé en 71 districts sanitaires (DS) qui représentent le niveau périphérique. Le DS est géré par une équipe cadre du district (ECD) composée de 5 à 8 personnes qui assurent sept fonctions principales (planification des activités, gestion des ressources, formation/encadrement du personnel, supervision, approvisionnement en médicaments essentiels et génériques, gestion d'informations, recherche-action et participation communautaire).

La population bénéficiaire participe à la gestion du système de santé à travers les comités de gestion (COGES) au niveau du deuxième échelon et les comités de santé (COSA) au niveau du

premier échelon. Par ailleurs, le Congo a adopté une stratégie nationale de santé à base communautaire, qui emploie des relais communautaires dans les aires de santé. Ce sont des organes de participation communautaire qui soutiennent le fonctionnement du système de santé au niveau périphérique.

Le tableau III ci-après, présente la structuration du territoire en départements et districts sanitaires.

Tableau III : Structuration du territoire en départements et districts sanitaires.

N°	Départements	Districts sanitaires
1	Brazzaville	10
2	Pointe-Noire	7
3	Kouilou	3
4	Niari	5
5	Bouenza	5
6	Lékoumou	2
7	Pool	7
8	Plateaux	4
9	Cuvette	3
10	Cuvette-Ouest	2
11	Sangha	2
12	Likouala	2
Total		**52**

I.2.1.2 Organisation de l'offre des soins et services de santé

L'organisation opérationnelle des soins et services de santé est fondée sur le district sanitaire et les principes fondamentaux des soins de santé primaires.

L'offre est assurée par deux secteurs : public et privé à travers les formations sanitaires (FOSA), les laboratoires, les centres de traitement ambulatoires (CTA), les services de santé des armées et les centres de traitement antituberculeux (CAT) qui sont gérés par les programmes Sida (PNLS) et Tuberculose (PNLT).

- **Secteur public**

Le secteur public de soins est organisé en trois échelons :

- Le premier échelon, représenté par les établissements de premier contact, dont les centres de santé intégrés et les postes de santé. Le Congo dispose de deux types de CSI : (i) le CSI à paquet minimum d'activités standard (PMAS) qui offre les services de base incluant les activités curatives, préventives et promotionnelles et (ii) le CSI à paquet minimum d'activités élargi de type1 (PMAE1) qui offre les soins d'accouchement et paquet minimum d'activités élargi de type2 (PMAE2) qui offre les soins en plus, les soins d'accouchement et de chirurgie.
- Le deuxième échelon, représenté par le premier niveau de référence. L'hôpital de référence de district représente le deuxième niveau de soins. Le pays compte 31 hôpitaux de districts. Ces structures offrent le paquet complémentaire d'activités (PCA) qui comprend : (i) les consultations externes (ORL, stomatologie, ophtalmologie), (ii) les consultations de référence (patients référés/contre référés), (iii) les hospitalisations (médecine, pédiatrie, chirurgie et Gyneco-Obstetrique), (iv) les urgences, médicochirurgicales de base et (v) les explorations paracliniques de base (laboratoire et imagerie).
- Le troisième échelon qui représente le 2e niveau de référence. Le pays compte 10 hôpitaux généraux, dont quatre (04) à Brazzaville parmi lesquels un Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Trois (03) à Pointe-Noire, un (01) à Dolisie, un (01) à Owando et un (01) à Oyo. La qualité des soins offerts par ces hôpitaux n'est pas optimale et reste préoccupante.

En outre, il existe huit (08) structures sous tutelle d'appui au diagnostic et au traitement que sont : le Centre de traitement de l'insuffisance Rénale (CTIR), le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), l'Institut National de Biologie et de Veille Sanitaire (INBVS) , la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé (CAMEPS), les deux (02) centres de traitement ambulatoires du VIH/SIDA (CTA), les deux (02) centres de traitement ambulatoire de la Tuberculose (CAT) et le Centre National de Référence de la Drépanocytose (CNRD. Il existe un projet de centre national de traitement de l'insuffisance rénale non fonctionnelle jusqu'à ce jour (local non achevé, matériels non disponibles, absence de ressources humaines) à Pointe-Noire.

- **Secteur privé**

Le **décret n°88-430 du 6 juin 1988** a favorisé l'essor du secteur sanitaire privé, qui s'est développé avec la croissance d'établissements privés de toute catégorie (polycliniques, cliniques, centres et cabinets médicaux, officines de pharmacie, infirmeries privées) dont certains offrent des soins d'hémodialyse, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire.

I.2.1.3 Déterminants socio-sanitaires

- **Pauvreté et revenu des ménages**

L'Enquête Congolaise des Ménages (ECOM-2011) avait évalué le taux de pauvreté à 46,5 % au Congo alors que l'estimation de la Banque mondiale en 2021 était de 52 %. Cette pauvreté est plus marquée en milieu rural qu'en milieu urbain. Elle limite l'accessibilité des populations aux services sociaux de base, en particulier aux soins et services de santé, y compris les services de prévention des maladies rénales.

- **Education**

Selon le diagnostic établi dans le PND (2018-2022), le cycle d'enseignement du préscolaire est en pleine émergence et se caractérise par un faible taux de couverture nationale (20 % en 2015) qui est encore en deçà de la cible de 30 % fixée à l'horizon 2024. En effet, les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans, qui représentent 31 % de la population générale du Congo selon le RGPH 2007, constituent une couche de population à risque et vulnérable. Car, à cette période de la vie, les relations sexuelles sont généralement instables et le multipartenariat est fréquent. Les comportements à risque observés dans cette tranche d'âge se caractérisent par la consommation du tabac, d'alcool et de substances toxiques, sur un terrain de sexualité précoce, avec une faible prévalence contraceptive et utilisation des préservatifs. Cela les expose aux grossesses précoces et non désirées, aux avortements clandestins et à des violences de toute nature, notamment celles basées sur le genre, ainsi qu'aux IST.

Parmi les facteurs déterminants ces pratiques, on peut retenir l'ignorance, la difficulté d'insertion socio-économique, les pesanteurs socioculturelles, la non-application de quelques textes et lois protégeant cette tranche d'âge, et l'insuffisance des services socioculturels habiletés pour la prise en charge. In fine, les adolescents et les jeunes, par leur comportement, sont potentiellement exposés au cancer dans une dizaine d'années si aucune stratégie de prévention et de promotion de la santé n'est mise en œuvre.

- **Eau, Hygiène et assainissement (WASH)**

L'hygiène du milieu se définit comme l'ensemble des mesures visant à anticiper l'apparition des maladies d'origines environnementales. Son objectif est d'assurer la salubrité d'un environnement pour la prévention et le contrôle des maladies. Par exemple, l'eau polluée

contient des agents microbiologiques (présence de bactéries, virus ou parasites) ou chimiques. En dehors des intoxications ponctuelles, la plupart des pathologies observées sont liées à la pollution chimique de l'eau de distribution, comme des cancers qui résultent d'une exposition chronique présente dans l'eau de consommation. D'autres sont des substances cancérogènes suspectées, telles que : les sous-produits de désinfection et les nitrates. Les pesticides relégués dans l'eau sont également suspectés de jouer un rôle dans l'apparition de certains cancers.

C'est pourquoi, il est recommandé de vivre dans un environnement sain, propre et bien entretenu, mais aussi de pratiquer le sport régulièrement et de changer les habitudes alimentaires.

- **Changements climatiques**

Les menaces causées par les effets du changement climatique, tant présents qu'à venir, qui influencent négativement le développement économique du Congo, sont faiblement documentées. Les chocs climatiques occasionnés par les actions humaines se situent dans un contexte largement ignoré, ne permettant pas de comprendre les impacts du changement climatique sur le développement humain.

Selon le PNUD, les effets du changement climatique observés au Congo, à travers la modification du calendrier cultural, sont : la vulnérabilité de la zone côtière, la dégradation des sols, les érosions pluviales et les inondations consécutives des terrains.

I.3 Situation épidémiologique de l'insuffisance rénale

I.3.1 Situation mondiale de l'insuffisance rénale et des maladies rénales

Dans le monde, les derniers chiffres prévoient une augmentation de près de 20 % des maladies rénales durant la prochaine décennie. La maladie rénale chronique (MRC) affecte plus de 850 millions de personnes dans le monde, soit un adulte sur dix et provoque au moins 2,4 millions de décès par an dus à l'insuffisance rénale. Elle est la 6e cause de mortalité croissante par ordre d'importance et décrite par l'OMS comme la maladie chronique la plus négligée. Car, très récemment, la connaissance de l'épidémiologie de l'insuffisance rénale chronique se limitait à celle des traitements de suppléance par dialyse ou greffe rénale. Avec l'augmentation de l'incidence et de la prévalence de l'insuffisance rénale terminale dans le monde, ainsi que de la morbidité, de la mortalité cardiovasculaire et des coûts élevés qui y sont associés, un intérêt croissant est porté aux stades précoces de la maladie rénale chronique, désormais considérée comme un problème majeur de santé publique de notre époque (2)

Aux USA la MRC est très élevée, concernant plus de 250 personnes pour 1 million (1) ; c'est aussi le cas du Brésil, de la Chine et du reste de l'Asie qui voient cette maladie croître fortement.

L'Insuffisance Rénale Aiguë consistant en la chute brutale du débit de filtration glomérulaire conduisant à l'altération de la fonction rénale est très grave, car elle conduit à plus de 50 % de mortalité. Elle est assez répandue aujourd'hui et atteint 13 millions de cas par an dans le monde, dont 11 millions dans les pays à faible revenu, en particulier l'Afrique, bien que les difficultés soient nombreuses pour faire une évaluation. Elle cause 1,7 million de décès par an, dont 1,4 million dans les pays pauvres. Pourtant, le plus souvent, l'IRA pourrait être prévenue, limitée et traitée, si les moyens et équipements de diagnostic étaient disponibles et suffisants. Des soins précoces permettent une vraie récupération rénale.

Par contre, les facteurs de risque modifiables, tels que l'inactivité physique, une mauvaise alimentation et l'usage nocif de l'alcool, augmentent le risque de maladie rénale chronique et donc de l'insuffisance rénale chronique.

- 1,8 million de décès annuels ont été attribués à une consommation excessive de sel/sodium.
- Sur les 3 millions de décès annuels attribuables à la consommation d'alcool, plus de la moitié sont dus à des MNT.
- 830 000 décès par an résultent d'une activité physique insuffisante.

Les facteurs de risque métaboliques contribuent à quatre changements métaboliques clés qui augmentent le risque de la maladie rénale chronique :

- L'hypertension artérielle (première cause de maladie rénale chronique en Afrique noire et deuxième cause en occident) (7) ;
- Le surpoids/obésité ;
- L'hyperglycémie (deuxième cause de l'insuffisance rénale chronique) ;
- L'hyperlipidémie (taux élevés de graisse dans le sang).

La maladie rénale est donc un problème de santé publique de plus en plus important en raison du grand nombre de patients touchés, des faibles niveaux de sensibilisation, de l'interaction avec d'autres maladies, des défis associés en matière de diagnostic et de prise en charge et du coût élevé des soins. Ces défis sont particulièrement préoccupants dans les milieux à faibles ressources, où les décideurs doivent faire des choix de ressources afin d'assurer un accès équitable aux traitements malgré la rareté des priorités concurrentes.

L'augmentation du nombre de personnes souffrant d'IR demeure préoccupante quant au recours à la thérapie de suppléance rénale (TSR) pour leur survie. Seulement 3 millions d'insuffisants

rénaux accèdent à la TSR. Selon les estimations, 2,3 à 7,1 millions décèdent chaque année pour non-accès à la thérapie de suppléance rénale. La plupart de ces décès surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Avec une politique de sensibilisation insuffisante et un accroissement de l'accès au diagnostic et au traitement, le nombre de personnes sous thérapie de suppléance rénale pourrait atteindre les 5.4 millions en 2030, constituant un véritable défi pour les systèmes sanitaires.

Les données des pays à revenu faible et intermédiaire montrent que même si les patients ont la possibilité d'accéder à la dialyse, ils abandonnent souvent et sont incapables de poursuivre le traitement à long terme. L'accès faible et inéquitable, le lourd fardeau des comorbidités, la progression rapide de la maladie liée au manque d'accès au service de prévention et à l'absence de subvention du traitement, constituent de véritables barrières à la thérapie de suppléance dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les patients sont perdus de vue à chaque étape du système de soins, soit parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, soit parce qu'ils ne peuvent pas continuer en raison de difficultés financières.

I.3.2 Situation de l'insuffisance rénale en Afrique

En Afrique, la prévalence de la maladie rénale chronique était estimée à 8 % en 2016 et plus importante en Afrique subsaharienne avec un taux de 13,9 %. Les projections d'ici à 2030 prévoient que plus de 70 % de la population mondiale avec insuffisance rénale chronique terminale se retrouveront dans les pays à ressources limitées comme en Afrique Subsaharienne. Il faudra noter qu'en 2004 uniquement 5 % de cette population avait accès au traitement par suppléance rénale. L'insuffisance rénale chronique est un fardeau en Afrique subsaharienne avec une mortalité hospitalière de 27,8 % en Côte d'Ivoire (3,6) et 28,87 % à Madagascar (5). Ce taux peut parfois atteindre 50 % selon certains auteurs africains. Cette forte mortalité est en rapport avec l'inaccessibilité à la dialyse pour le plus grand nombre de patients. En Afrique centrale, la prévalence de l'IRA est estimée à 23,5 %.

I.3.3 Situation de l'insuffisance rénale au niveau national

I.3.3.1 Données épidémiologiques de l'insuffisance rénale

Le CHU de Brazzaville a rapporté, de 2016 à 2018, 497 patients (52,1 % des patients admis) atteints d'insuffisance rénale chronique, soit 166 nouveaux patients/an. Leur âge moyen était de 51,8 ± 15,2 ans, avec une prédominance masculine (59,1 %).

Les trois premières néphropathies causales étaient le diabète sucré (23,3 %), l'hypertension artérielle (21,8 %) et les glomérulonéphrites chroniques non diabétiques (15,5 %). Dans 22,3%

des cas, la néphropathie causale est restée indéterminée. L'IRC a été déclarée terminale chez 295 patients (74,2 %) ; dont 73 (19,8 %) ont pu avoir accès à la dialyse. Le taux de létalité était de 49,9% (8,10).

A Pointe-Noire, l'hôpital Adolphe-SICE a rapporté, de 2018 à 2019, 368 cas d'insuffisance rénale, dont 208 hommes (56 %). L'IRA était notée dans 196 cas (53 %) et l'IRC dans 172 cas (47 %), soit 86 nouveaux cas d'IRC/an. L'âge moyen était de 52 ans (6 mois-94 ans). Concernant l'HTA (49%), les néphropathies étaient probablement vasculaires (62 cas), mixtes (54 cas), glomérulaires (24 cas), tubulo-interstitielles (22 cas), indéterminées (7 cas) et héréditaires (3 cas). L'hémodialyse était indiquée chez 137 cas (37 %), elle n'a pu être effectuée pour 11 patients (8 %). Il y a eu 115 décès, soit 31,25 %.

En accumulant l'incidence annuelle des cas d'IRC dans les deux (2) grandes villes du pays, nous avons 338 nouveaux cas d'IRC/an ; avec un faible accès à l'hémodialyse, dont la moyenne est de 13,9 % et une létalité de 51 %.

I.3.3.2 Les hémodialysés chroniques au Congo

A ce jour, le Congo compte six centres d'hémodialyse, dont quatre dans le secteur privé (2 à Pointe-Noire et 2 à Brazzaville); et deux dans le secteur public hospitalier (Oyo et Brazzaville). On comptait la même année 17 générateurs d'hémodialyse sur toute l'étendue du territoire nationale, repartis dans ces différents centres. La figure 2 représente la répartition des centres d'hémodialyse au Congo en 2020. En 2021, le Congo comptait 93 patients hémodialysés chroniques réguliers depuis au moins 3 mois. **Le taux d'accès à l'hémodialyse est estimé à 13,9 % en 2021** (9).

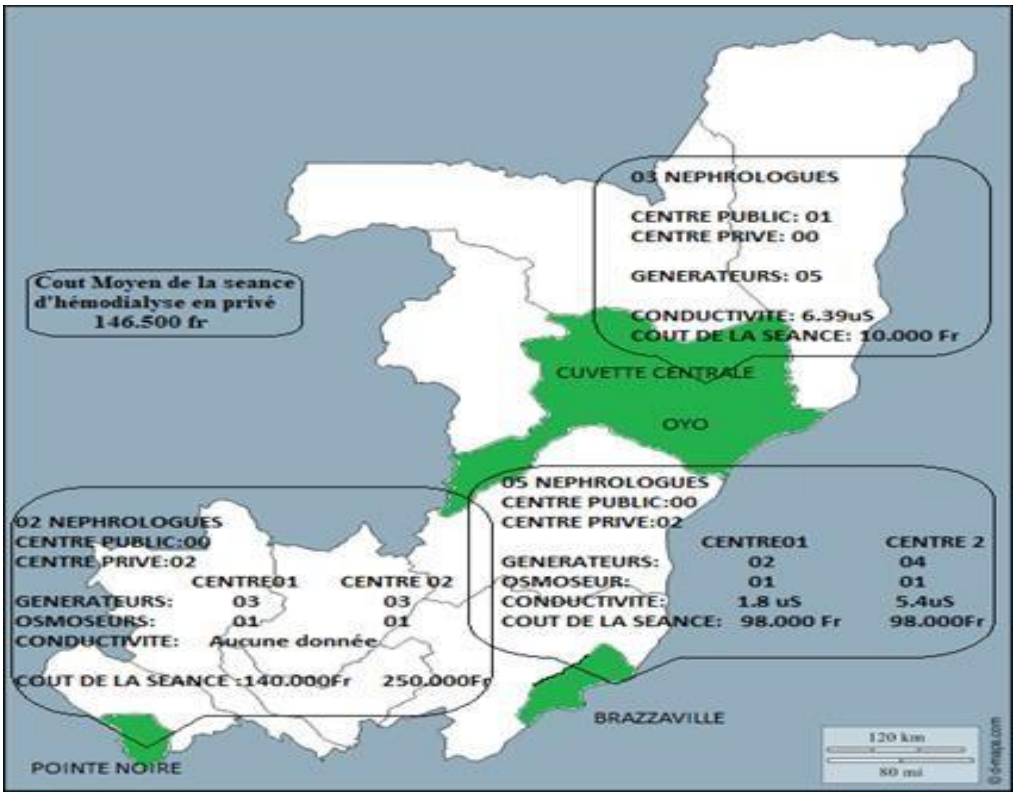


Figure 3 : cartographie des centres d'hémodialyse en république du Congo.

I.3.3.3 Ressources humaines pour la prise en charge de l'insuffisance rénale

En 2021, le Congo comptait trois (3) services de néphrologie, dont un à Pointe-Noire, un à Brazzaville et un à Oyo. Le tableau IV présente les différentes catégories des ressources humaines à la prise en charge des patients en IRCT, disponibles au Congo en 2021.

Tableau IV : Répartition des ressources humaines par catégorie pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique au stade de dialyse au Congo en 2021.

Ressources humaines	Effectifs (n)
Néphrologues	**9**
IDE en hémodialyse	**3**
Technicien biomédical en hémodialyse	**2**
IDE généraliste avec aptitude en hémodialyse	**15**

I.3.3.4 Les facteurs de risque de l'insuffisance rénale

Dans le cadre de l'IRC, les principaux facteurs de risque en Afrique subsaharienne en général et au Congo en particulier sont l'HTA et le diabète. Ces deux facteurs représentent, à eux seuls, près de la moitié (48,9 %) des causes de l'IR chronique. Ils sont suivis par le VIH et la toxicité

médicamenteuse liée à l'automédication, aux produits traditionnels, à l'alcool, le tabac... Dans le cadre de l'IRA, la toxicité médicamenteuse et les accouchements compliqués sont les principaux facteurs de risque rapportés par le CHU de Brazzaville en 2021.

- **L'hypertension artérielle (8)**

L'hypertension artérielle (HTA) est un problème majeur de santé publique en Afrique subsaharienne, avec une prévalence sans cesse croissante et une surmortalité due essentiellement à l'accès limité aux soins et à une méconnaissance de la maladie. La prise en charge de cette HTA reste difficile, car de survenue précoce et souvent sévère, responsable de nombreuses complications à la fois cardiaques, cérébrales et rénales. Au Congo, la prévalence de l'HTA était estimée à 32,5 % à Brazzaville.

Dans le cadre de la stratégie WHOpen, qui vise à intégrer et à décentraliser la prise en charge des maladies non transmissibles (HTA et diabète de type 2) dans les centres de santé primaires, une phase pilote a été déployée dans 18 districts sanitaires : 10 à Brazzaville, 7 à Pointe-Noire et 1 au Kouilou. Les résultats du dépistage dans ces districts ont révélé une prévalence de l'HTA de 32,17 % sur 46 044 personnes testées. Parmi ces cas, 6 715 nouveaux diagnostics ont été posés, avec une prédominance chez les femmes (60,3 %) et dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans (34,2 %). En complément, la campagne de dépistage organisée en novembre 2024, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, a permis d'affiner ces observations. Sur 543 personnes dépistées, la prévalence globale de l'HTA était de 40,7 %, atteignant 63,7 % chez les 60 ans et plus, tandis que 29,1 % des cas concernaient des personnes nouvellement diagnostiquées.

- **Le diabète sucré**

Dans le monde, 55 % des personnes diabétiques connaissent leur statut. Dans la région africaine, le manque de structures et d'équipements de dépistage, le nombre inadéquat de personnel de santé formé, l'accès insuffisant aux établissements de santé et le manque de sensibilisation sur le diabète constituent des obstacles à l'accès au dépistage du diabète. Actuellement, 24 millions d'adultes vivent avec le diabète en Afrique. Ce nombre devrait augmenter pour passer à 55 millions de personnes d'ici à 2045. Dans la région africaine, la proportion de décès prématurés dus au diabète (définis comme survenant avant l'âge de 70 ans) s'élève à 58 %, soit plus que la moyenne mondiale de 48 %. Le taux de mortalité normalisé en fonction de l'âge (un ajustement mathématique des différentes populations pour obtenir la

même structure) pour le diabète est de 48 pour 100 000 personnes dans la région, ce qui représente plus du double du taux mondial de 23 pour 100 000 personnes.

Au Congo, le diabète constitue la première cause d'insuffisance rénale selon les données hospitalières : 45 % des cas d'insuffisance rénale concernent les sujets diabétiques. Les données issues de la phase pilote de WHOpen ont également mis en évidence une prévalence élevée du diabète sucré 23,9 % (52 950 personnes dépistées) dans les 18 districts sanitaires concernés. Parmi ces cas, 4 954 ont été nouvellement diagnostiqués, avec une prédominance chez les femmes (61,2 %) et dans la tranche d'âge des 25-44 ans (33,8 %). La campagne de dépistage organisée en novembre 2024 à Brazzaville a confirmé cette tendance, avec une prévalence globale de 14,7 % parmi les 543 personnes testées. Une augmentation progressive de la prévalence avec l'âge a été observée, passant de 4,3 % chez les 18-29 ans à 23,5 % chez les 60 ans et plus. Chez les personnes nouvellement diagnostiquées, la prévalence s'élevait à 5,1 %.

- **La toxicité médicamenteuse**
  - **L'automédication**

Selon l'OMS, l'automédication consiste dans le fait qu'un individu recourt à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche, dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié, sans avoir recours à un professionnel de santé. Il s'agit d'une pratique très répandue dans le monde qui concerne 50 à 75 % de la population ; dont la prévalence varie considérablement selon les régions, les groupes socio-économiques et les contextes culturels. Une méta-analyse de l'OMS couvrant la période de 2000 à 2018 a estimé que 67 % des personnes dans le monde ont recours à l'automédication au moins une fois. La prévalence la plus élevée a été observée en Europe de l'Est, atteignant 74 %, et en Asie, elle variait entre 71 % à 83 % selon les pays. En Afrique subsaharienne, la prévalence moyenne est estimée à 55,2 %, dont la plus élevée a été observée à 92,2 % au Nigeria. En République Démocratique du Congo (RDC), la prévalence a été estimée à 49 % en 2017 sur l'ensemble de la population.

Bien que peu d'études quantitatives soient publiées à grande échelle sur l'automédication en République du Congo, les enquêtes locales et les observations de terrain montrent que l'automédication est une pratique courante, particulièrement en milieu urbain comme à Brazzaville et à Pointe-Noire. Une étude qualitative menée à Brazzaville sur les femmes âgées de 15 à 29 ans révèle une forte fréquence d'automédication, notamment dans le domaine de la santé reproductive, dont 77 % des cas utilisaient les médicaments issus des pharmacies de la rue et 48 % dans le traitement des infections génitales. Une autre étude menée au Cameroun a

révélé que parmi les patients pratiquant l'automédication, 65,9 % présentaient une insuffisance rénale aigue et 34,1 % une insuffisance rénale chronique.

- **Consommation nocive des remèdes traditionnels**

La médecine traditionnelle est largement utilisée en Afrique subsaharienne, avec environ 80 % de la population y ayant recours. Cependant, l'utilisation de certaines plantes médicinales peut entraîner des intoxications en raison de dosages imprécis ou de composés toxiques présents dans ces plantes. Certaines plantes utilisées en médecine traditionnelle ont été identifiées comme potentiellement néphrotoxiques. Les données spécifiques sur la prévalence de l'utilisation des remèdes traditionnels en République du Congo sont limitées.

- **La consommation du tabac**

Selon le rapport de l'OMS de 2023, environ 22,3 % de la population mondiale âgée de 15 ans et plus consommaient du tabac en 2020, avec une prévalence de 36,7 % chez les hommes et 7,8 % chez les femmes. Approximativement 80 % des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à faible revenu. Une revue systématique publiée en 2023 indique que la prévalence du tabagisme à vie en Afrique subsaharienne est de 8,8 % avec une prévalence au cours de la dernière année de 10,8 % et un tabagisme quotidien de 3,5 %. Chez les adolescents, la prévalence à vie est de 4,5 %, avec une prévalence au cours de la dernière année de 5,8 % et un tabagisme quotidien de 1 %. Une étude publiée dans la revue Néphrologie et Thérapeutique a exploré les effets du tabac sur le rein, a souligné que le tabagisme est un facteur de risque indépendant pour le développement et la progression de l'insuffisance rénale chronique, notamment en raison de ses effets sur la pression artérielle, la fonction endothéliale et l'augmentation de la protéinurie. En République du Congo, en 2022, la prévalence du tabagisme chez les personnes âgées de plus de 15 ans était estimée à 14,4 % avec une disparité notable entre les sexes : 28,2 % chez les hommes et 0,8 % chez les femmes. Une étude en 2021 à Moungali a révélé une prévalence du tabagisme à 4,63 % chez les adultes. Une enquête menée en 2019 auprès des jeunes scolarisés de 13 à 15 ans a révélé une prévalence du tabagisme de 9,5 % avec une consommation de cigarettes électroniques de 6 % et une exposition au tabagisme passif de 21,9 %. Le Congo a mis en place un plan antitabac pour la période 2025-2029, visant à renforcer les mesures de prévention et de contrôle du tabagisme.

- **La consommation d'alcool**

À l'échelle mondiale, la consommation excessive d'alcool est responsable de 3 millions de décès par an, représentant 5,3 % de la mortalité totale. Selon les données de l'OMS, environ 400 millions de personnes âgées de 15 ans et plus présentaient des troubles liés à la consommation d'alcool en 2019, dont environ 209 millions souffraient de dépendance à l'alcool. En 2019, la consommation totale d'alcool était estimée à 5,5 litres d'alcool pur chez les personnes âgées de 15 ans et plus. La prévalence des troubles liés à la consommation d'alcool varie considérablement selon les régions. Les taux les plus élevés sont observés en Europe et en Amérique avec une prévalence de 14,8 % chez les hommes et de 3,5 % chez les femmes en Europe et de 11,5 % chez les hommes contre 5,1 % chez les femmes en Amérique. En Afrique subsaharienne, l'alcool est la substance la plus consommée et mal utilisée. En République du Congo, une étude a été menée à Brazzaville en 2004, révélant une prévalence élevée de la consommation excessive d'alcool parmi les adultes âgés de 25 à 64 ans, avec 61,1 % de buveurs identifiés parmi eux, 35,1 % étaient des consommateurs réguliers.

- **L'obésité**

L'obésité est devenue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale, avec des répercussions particulièrement graves sur la santé rénale. L'Organisation mondiale de la Santé rapporte que plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'obésité, incluant 650 millions d'adultes, 340 millions d'adolescents et 39 millions d'enfants. Ces chiffres ne cessent d'augmenter, avec une estimation de 167 millions de personnes supplémentaires en moins bonne santé due au surpoids ou à l'obésité d'ici à 2025. En Afrique subsaharienne, la prévalence moyenne est de 20,8 % chez les femmes et de 9,2 % chez les hommes. En RDC, la prévalence était de 11,6 % chez les femmes et de 4,5 % chez les hommes, tandis qu'en République du Congo, les prévalences étaient respectivement de 15,6 % chez les femmes et de 6,8 % chez les hommes.

En outre, plusieurs études montrent que l'obésité peut endommager les reins et entraîner une MRC (en altérant leur structure et leur fonctionnement). En France, une étude a montré que 15 % des hommes et des femmes obèses et en surpoids ont deux fois plus de risque de développer une IRCT. En Afrique subsaharienne, cette corrélation varie selon les régions et les études. En RDC, 10 % des personnes obèses développent une maladie rénale chronique et au Congo, les études indiquent une prévalence de l'obésité de 10 % parmi les patients atteints de maladies rénales chroniques.

II. DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE

Le Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR) a été créé par le Décret n° 2019-225 du 13 août 2019 portant création, attributions et organisation du PNLIR au Congo. Ce programme est placé sous l'autorité du Ministre chargé de la Santé. Il est chargé, notamment, de (d') :

- Organiser les activités préventives contre l'insuffisance rénale ;
- Informer et sensibiliser la population en général et particulièrement les groupes à risques ;
- Faciliter l'accessibilité aux soins d'hémodialyse, au bilan pré et post dialytique et aux médicaments ;
- Elaborer les bonnes pratiques pour une prise en charge optimale des sujets atteints d'insuffisance rénale ;
- Collecter et analyser les données statistiques du programme ;
- Planifier, coordonner et superviser les activités de lutte contre l'insuffisance rénale ;
- Emettre des recommandations de bonnes pratiques pour une prise en charge optimale des sujets atteints d'insuffisance rénale ;
- Mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre l'insuffisance rénale ;
- Promouvoir la recherche et la formation sur l'insuffisance rénale ;
- Participer à la mise en œuvre et au suivi des activités de partenariat.

Le programme national de lutte contre l'insuffisance rénale comprend la direction du programme et le comité scientifique d'appui.

II.1 La Direction du programme

La Direction du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale est dirigée et animée par un Directeur nommé par décret du Premier ministre, chef du Gouvernement, sur proposition du ministre en charge de la santé. A ce titre, il est chargé de (d') :

- Assurer la représentation du programme ;
- Coordonner les activités relatives aux missions du programme ;
- Assurer la gestion administrative, technique et financière du programme ;
- Elaborer les documents stratégiques de prise en charge de l'insuffisance rénale ;
- Elaborer et adopter les directives du programme ;

- Assurer de concert avec les structures du système sanitaire, le suivi et la mise en œuvre des directives du programme ;
- Veiller à l'élaboration des plans stratégiques et autres outils du programme ;
- Veiller à la validation du plan annuel d'activités et autres outils du programme ;
- Mettre en œuvre les activités découlant du plan d'activités ;
- Déterminer les besoins du programme et veiller à leur satisfaction ;
- Adresser tous les trimestres, au Ministre chargé de la Santé, un rapport d'activités portant sur la mise en œuvre du programme ;
- Mobiliser les ressources et rechercher les financements ;
- Evaluer les besoins en ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles
- Exécuter toute autre tâche utile au programme.

La Direction du programme, outre le secrétariat, comprend :

- Le Département de la Prévention et de la Prise en charge thérapeutique de l'insuffisance rénale ;
- Le Département du Dépistage et de la Surveillance épidémiologique de l'insuffisance R ;
- Le Département de la Recherche et de la Formation ;
- Le Département de la Gestion et de la Logistique ;
- Le Département de la Documentation, des Archives et de la Statistique.

II.2 Le Comité Scientifique du PNLIR

Le Comité Scientifique d'appui est l'organe qui assiste la Direction du programme. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- Participer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme ;
- Finaliser les outils de gestion élaborés par la Direction du programme.

Le Comité Scientifique d'appui est composé de quinze (15) spécialistes dans les disciplines suivantes :

- Néphrologie (3) ;
- Santé publique (1) ;
- Urologie-andrologie (2) ;
- Anatomie pathologique (1) ;
- Pédiatrie (1) ;
- Gynécologie-obstétrique (1) ;

- Médecine interne (2) ;
- Biologie médicale (1) ;
- Toxicologie (1) ;
- Imagerie médicale (1) ;
- Epidémiologie (1).

Le comité scientifique d'appui peut faire appel à toute personne ressource ou un consultant.

III. TROISIEME PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE ET IDENTIFICATION DES PROBLEMES PRIORITAIRES

III.1 Analyse de la situation

L'analyse de la situation actuelle de lutte contre l'insuffisance rénale au Congo repose sur l'approche d'analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM). Les tableaux V, VI, VII et VIII ci-dessous présentent les résultats de cette analyse, selon les orientations stratégiques traduites en programmes.

Tableau V: Présentation de l'analyse des FFOM sur le renforcement de la gouvernance, du leadership et pilotage du programme national de lutte contre l'insuffisance rénale .

Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale	
Sous-programme1-1. Renforcement de la Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale	
Forces	• Existence d'un PNDS 2023-2026 ; • Existence d'un décret portant création du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR) au Congo ; • Existence d'un arrêté portant nomination des chefs de Départements du PNLIR ; • Existence de la DGAR, de la DGPOP et le la DGSSSa.
Faiblesses	• Insuffisance de textes, décrets et lois d'application pour le fonctionnement du PNLIR. • Insuffisance quantitative et qualitative du personnel du PNLIR. • Absence d'un cadre juridique sur le don d'organe au Congo. • Insuffisance d'un cadre juridique et réglementaire pour la prise en charge des patients en dialyse chronique (textes de lois et textes d'application des lois y compris ceux sur la sûreté environnementale en hémodialyse).

Opportunités	• Existence d'une institution sectorielle de coopération internationale et de partenariat public-privé. • Existence d'une Association Congolaise des Patients en Hémodialyse. • Existence des institutions parlementaires (commissions de santé). • Existence des partenaires techniques et financiers.
Menaces	• Instabilité économique.

Sous-programme1-2. Mobilisation des fonds et développement du partenariat	
Forces	• Existence d'une ligne budgétaire de fonctionnement dédiée au PNLIR dans le budget de l'Etat ; • Existence d'un cadre de partenariat public-privé : protocole d'accord avec le laboratoire Roche ; • Institutionnalisation des comptes nationaux de la santé ; • Engagement de l'État dans l'allocation des ressources pour les dépenses de santé.
Faiblesses	• Insuffisance de partenariat et absence d'un organe de coordination des interventions de lutte contre les maladies non transmissibles ; • Faible capacité de mobilisation des fonds pour les interventions du programme ; • Faible taux de décaissement des fonds de fonctionnement dédiée au PNLIR ; • Faible allocation budgétaire affectée au PNLIR.
Opportunités	• Existence de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ; • Partenariat avec le laboratoire pharmaceutique (Roche).
Menaces	• Instabilité économique; • procédure complexe de décaissement des fonds alloués au fonctionnement du PNLIR.

Tableau VI :Présentation de l'analyse des FFOM sur le renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR.

Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR	
Forces	• Existence d'un décret portant création des districts sanitaires ; • Adoption des soins de santé primaires comme stratégie du développement sanitaire ; • Existences de onze (11) spécialistes qualifiés en néphrologie dans le pays (Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo) ; • Existence de deux (2) centres de dialyse publique intra hospitalier (CHU, HGLBO) ; • Existence des services de néphrologie dans les hôpitaux généraux du pays ; • Existence d'un Programme Elargi de Vaccination.

Faiblesses	• Absence d'intégration du dépistage et de la prise en charge de l'insuffisance rénale dans les soins de santé primaires ; • Absence des algorithmes de dépistage et de prise en charge de l'insuffisance rénale ; • Insuffisance de personnels formés sur le dépistage et la prise en charge de l'insuffisance rénale dans les FOSA du niveau périphérique (districts sanitaires) ; • Insuffisance de plateau technique dans les FOSA des districts sanitaires sur le dépistage et la prise en charge de l'insuffisance rénale ; • Insuffisance de centres de dialyse publics dans le pays ; • Absence de centre de dialyse public dans le Département de Point Noire ; • Manque de gratuité des érythropoïétines, du fer injectable Sevelamer et dapagliflozine ; • Manque d'une politique de gratuité de la dialyse ; • Insuffisance des médicaments essentiels génériques contre les complications liées à l'insuffisance rénale chronique dans le pays ; • Insuffisance du personnel qualifié en hémodialyse (médecins, infirmiers, techniciens...).
Opportunités	• Existence des écoles de formation de ressources humaines en santé (Faculté des Sciences de la Santé, Écoles Paramédicales et des Services Sociaux) ; • Existence des centres de dialyse privés ; • Existence des partenaires techniques et financiers.
Menaces	• Instabilité institutionnelle ; • Faible couverture vaccinale d'hépatite B chez les patients souffrant d'IRCT ; • Défaillante de la gestion des MEG et des produits pour l'insuffisance rénale chronique ; • Faible pouvoir d'achat des populations.

Tableau VII : Présentation de l'analyse des FFOM sur la promotion de la sante rénale.

Programme 3. Promotion de la santé rénale	
Forces	• Existence d'un guide SMIR 2018 ; • Existence d'une Politique Nationale de Promotion de la santé ; • Existence d'une Direction de l'Hygiène et de la Promotion de la Santé ; • Existence des comités de santé (COSA) et des comités de gestion (COGES) ; • Organisation d'une campagne annuelle de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des cas d'insuffisance rénale ; • Existence d'une Direction de la Santé Scolaire et Universitaire ;

Programme 3. Promotion de la santé rénale	
	• Institutionnalisation des Journées Internationales du Rein ainsi que des principaux facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique (HTA, diabète sucré, tabac, obésité ...) ; • Existence d'un service de communication au PNLIR (réseaux sociaux, un numéro du PNLIR ...) pour les informations et la sensibilisation permanentes sur l'insuffisance rénale.
Faiblesses	• Absence d'un plan de communication sur la lutte contre l'IR ; • Insuffisance d'activité de prévention de l'insuffisance rénale et de promotion de santé rénale en milieu scolaire et professionnel ; • Faible collaboration avec les DS (absence des points focaux, etc.); • Absence d'un site web pour le programme ; • Absence d'intégration des activités en lien avec la lutte contre l'insuffisance rénale, dans le paquet de services des relais communautaires (RECO) ; • Insuffisance des fonds mobilisés pour la promotion de la santé rénale ; • Insuffisance des connaissances du personnel soignant des CSI sur les maladies rénales ; • Faible utilisation des outils et canaux de communication pour la promotion de la santé et la lutte contre l'insuffisance rénale.
Opportunités	• Appui des partenaires techniques et financiers.
Menaces	• Non-décaissement de la contrepartie financière de l'Etat pour la mise en œuvre des interventions de lutte contre l'insuffisance rénale et la promotion de la santé rénale ; • Instabilité économique.

Tableau VIII : Présentation de l'analyse des FFOM sur la gestion de l'information sanitaire et la recherche sur l'insuffisance rénale .

Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la Recherche sur l'insuffisance rénale	
Forces	• Existence de la Direction de l'Information Sanitaire, d'Evaluation et de la recherche ; • Existence de la plateforme DHIS2 ; • Existence d'un partenariat entre le MSP, Ministère de l'Enseignement supérieur et le Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.
Faiblesses	• Absence d'outils de collecte des données sur l'insuffisance rénale au niveau national ; • Absence d'une étude d'envergure nationale sur la maladie rénale et ses facteurs de risque ; • Non-paramétrage des indicateurs de l'insuffisance rénale dans DHIS2 ; • Absence d'une collaboration entre les autres structures de gestion des données sanitaires (INS…) et celle du Ministère de la Santé et de la Population ; • Absence d'un système de surveillance épidémiologique de l'insuffisance rénale.
Opportunités	• Existence des institutions de recherche en science de la santé ; • Existence d'un partenariat avec le laboratoire Roche.
Menaces	• Insuffisance de financement pour la recherche en santé.

III.2 Identification des problèmes prioritaires

Au terme de l'analyse de la situation de lutte contre l'insuffisance rénale au Congo, six (6) problèmes majeurs ont été identifiés, notamment :

Piliers	Problème principal	Problèmes prioritaires (Causes immédiates)	Causes sous-jacentes	Causes profondes
1. Gouvernance, leadership et pilotage	Prévalence élevée de l'IR à 7,6 avec une létalité de 32,2 % au CHU de Brazzaville	Faible capacité de gouvernance, de leadership et du pilotage du Programme	• Faible mobilisation des partenaires • Manque de projet de plaidoyer sur les problèmes et besoins du PNLIR • Insuffisance de protocole d'accord signé avec les partenaires associés • Faible intégration des composantes IR dans les microplans des déconcentrés (districts sanitaires). • Manque d'une politique de gratuité de la prise en charge de l'IR. • Faible budgétisation selon le concept Budget-Programme.	• Lourdeur de la procédure de décaissement des fonds alloués au PNLIR. • Faible mobilisation des ressources auprès des PTF. • Faible implication des gouvernants. • Méconnaissance des nouvelles directives CEMAC sur la gestion des fonds publics.

2. **Financement et mobilisation de ressources**.		Faible mobilisation des ressources financières internes et externes indispensables à la lutte contre l'insuffisance rénale.	• Ligne budgétaire insuffisante. • Insuffisance des fonds d'investissement. • Faible taux de décaissement.	• Complexité du mécanisme de décaissement de la ligne budgétaire. • Absence d'un manuel de procédure de gestion administrative et financière. • Instabilité économique.
3. Offre de soins et de services de santé		• Insuffisance des normes et des procédures sur l'offre des soins et des services en lien avec l'insuffisance rénale.	• Absence des algorithmes sur le dépistage et le diagnostic de l'IR. • Non intégration des activités de dépistage et de prise en charge de l'insuffisance rénale au niveau opérationnel ; • Insuffisance de centres de dialyse publique dans la ville Pointe-Noire • Faible accès de la population aux services de dépistage et de prise en charge de l'IR.	• Faible mobilisation des gouvernants ; • Manque d'actualisation du PMA et PCA des FOSA. • Insuffisance des textes règlementaires de l'offre de soins et de services de l'IR ; • Non-intégration de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR dans les plans d'actions des DS.

4. Technologies de santé, Médicaments et vaccins		• Manque d'une politique de gratuité de la prise en charge de l'IR.	• Non gratuité de l'érythropoïétine, du fer injectable, Sevelamer, dapagliflozine et de la dialyse. • Faible couverture vaccinale de l'hépatite B des patients IRCT. • Faible intégration des produits de la prise en charge de l'IR dans la liste nationale des médicaments,	• Faible capacité en technologies de santé, médicaments et vaccins. • Faible implication des décideurs, acteurs et PTF dans la lutte contre l'IR.
5. Gestion de l'information sanitaire.		• Insuffisance des bases factuelles de de données sur l'IR	• Sous notification des cas et décès dus aux IR dans les hôpitaux. • Insuffisance des études de recherche sur les maladies rénales. • Absence des outils de collecte et de gestion de données sur l'IR. • Non-opérationnalité du système de surveillance épidémiologique de l'IR au niveau national. • Manque de points focaux et de gestionnaires de données formés sur les IR au niveau des DDSSSa, DS et HG/HR).	• Manque de paramétrage des indicateurs d'IR dans DHIS2. • Manque d'un système de surveillance épidémiologique des maladies rénales et de gestion de données. • Manque de formation des acteurs sur la gestion de données liées à l'IR.

6. Personnel de santé		• Insuffisance des acteurs de santé qualifiés et formés sur le dépistage et la PEC de l'IR.	• Insuffisance du personnel qualifié et formé en hémodialyse ; • Insuffisance de techniciens en hémodialyse • Insuffisance des néphrologues.	• Insuffisance de formations appropriées sur les maladies rénales. • Faible implication des acteurs dans les études de recherche sur l'insuffisance rénale.

IV. QUATRIEME PARTIE : STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE AU CONGO

IV.1 But et Vision

IV.1.1 Vision

Une population congolaise protégée contre l'insuffisance rénale et bénéficiant d'un accès équitable à des services de prévention, de diagnostic et de prise en charge de qualité.

IV.1.2 But

Réduire la morbidité et la mortalité liées à l'insuffisance rénale en République du Congo.

IV.1.3 Objectifs

IV.1.3.1 Objectif stratégique

L'objectif stratégique est de réduire de 75 % la morbidité et de 50% la mortalité liées à l'Insuffisance Rénale par la prévention de la maladie, la promotion de la santé rénale et la prise en charge efficace d'ici à 2029.

IV.1.3.2 Objectifs spécifiques et résultats attendues

L'objectif stratégique sera atteint à travers les huit (08) objectifs spécifiques et les 17 résultats attendus ci-après :

Tableau IX : Présentation des objectifs et résultats attendus du PSN.

Objectifs spécifiques (OS)	Résultats attendus
Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale	
Sous-programme1.1. Renforcement de la gouvernance, du leadership et du pilotage des activités du Programme National de **de la lutte contre l'Insuffisance Rénale**	
OS. 1. Renforcer la gouvernance, le leadership et le pilotage des activités du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale au Congo.	**Résultat attendu n°1** : au moins 70% des textes (lois, décrets, arrêtés, notes de services) réglementant la prise en charge de l'insuffisance rénale au Congo ainsi que des documents stratégiques, normatifs et procéduraux du PNLIR sont élaborés, validés et disponibles.
Sous-programme1-2. Mobilisation des fonds et développement du partenariat	
OS 2. Mobiliser les fonds suffisants et durables pour la lutte contre L'insuffisance rénale et le développement du partenariat.	**Résultat attendu n°2** : au moins 75 % des fonds indispensables à la mise en œuvre des interventions de lutte contre l'insuffisance rénale sont mobilisés
	Résultat attendu n°3 :au moins 25% des Organismes du Système des Nations Unies et d'autres partenaires et bailleurs collaborent avec le PNLIR au niveau national et international.
Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR	
OS 3. Renforcer l'offre de soins et des services de prise en charge de l'insuffisance rénale.	**Résultat attendu n° 4** : le dépistage et la prise en charge de l'insuffisance rénale sont intégrés dans le paquet des soins de santé primaires (SSP).
	Résultat attendu n° 5 : l'offre de soins et la prise en charge de l'IR sont intégrées et opérationnelles dans les districts sanitaires
	Résultat attendu n° 6 : au moins 20 néphrologues et 40 personnels soignants en dialyse sont formés et mis sur le terrain
	Résultat attendu n°7 : au moins 75% des hôpitaux généraux et 50% des hôpitaux de base disposent d'un service de néphrologie.
	Résultat attendu n°8 : au moins deux (2) hôpitaux généraux à B/ville et P/N disposent d'un centre de dialyse intra-hospitalier construit, équipé et fonctionnel.
	Résultat Attendu n° 9 : au moins 75% des patients souffrant d'IRCT ont accès à la dialyse.

Objectifs spécifiques (OS)	Résultats attendus
OS 4. Améliorer l'accessibilité des patients aux soins et services de prise en charge de l'IR.	**Résultat attendu n°10** : au moins 75% de la gamme des produits de l'IR (l'érythropoïétine, le fer injectable, Sevelamer et dapagliflozine) sont gratuits et disponibles.
	Résultat attendu n° 11 : au moins 95% des patients souffrant d'IRCT sont immunisés contre l'hépatite B.
OS 5. Renforcer la collaboration avec la CAMEPS pour la gestion de médicaments et consommables de la dialyse.	**Résultat attendu n°12** : le PNLIR collabore avec la CAMEPS sur la gestion des médicaments et consommables de la dialyse et le ravitaillement des départements de Brazzaville et P/N.
Programme 3. Promotion de la santé rénale	
OS 6. Renforcer la prévention de l'insuffisance rénale et la promotion de la santé rénale dans la population générale et à risque	**Résultat attendu n°13 :** au moins 70% de la population générale est sensibilisée sur les facteurs de risque de l'IR et 80% des IR sont détectés précocement et prise en charge.
	Résultat attendu n° 14 : au moins 80% des populations à risque d'IR (HTA, diabète sucré, obésité...) sensibilisées sur les maladies rénales, acquièrent un plus grand contrôle de leur propre santé et l'améliorent.
Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale	
OS 7. Mettre en place un système de surveillance épidémiologique et de gestion de données sur l'IR	**Résultats attendus n°15** : les outils de collecte de données et les indicateurs de surveillance épidémiologique de l'IR sont disponibles et paramétrés dans le. DHIS2.
	Résultats attendus n°16 : un système résilient de surveillance de l'IR (cas et décès) est développé au PNLIR
OS 8. Promouvoir la recherche opérationnelle sur l'IR.	**Résultat Attendu n°17** : les bases factuelles issues de la recherche sur l'IR sont disponibles.

IV.2 Orientations Stratégiques

Les orientations stratégiques du PSN se déclinent en quatre programmes bien définis.

- **Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de la Lutte contre l'Insuffisance Rénale**

Ce programme est composé de deus sous programmes, notamment :

- **Sous-programme1-1. Renforcement de la Gouvernance, du leadership et du pilotage des activités du Programme National** de **la Lutte contre l'Insuffisance Rénale**

Sur cet axe, il s'agira de mettre en œuvre les interventions à haut impact ci-après :

- Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre l'insuffisance rénale au Congo ;
- Renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et interventionnelles du PNLIR ;
- Renforcement du cadre juridique et réglementaire de la prise en charge de l'insuffisance rénale au Congo (cadre réglementaire des centres d'hémodialyse, cadre juridique de la transplantation d'organe au Congo).

- **Sous-programme1-2. Mobilisation des fonds et développement du partenariat**

Sur cet axe, il s'agira principalement de mettre en œuvre les activités suivantes :

- Mobilisation de financement des activités de lutte contre l'insuffisance rénale
- Amélioration de l'accès financier aux soins de la population ;
- Investissement des partenaires dans les interventions de lutte contre l'insuffisance rénale.

- **Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR**

- Intégration du dépistage et prise en charge de l'IR dans les soins de santé primaires
- Intégration des activités de dépistage et de prise en charge des maladies rénales dans les PMA, PMAE et PCA des FOSA (districts sanitaires) ;
  renforcement de capacités des prestataires de soins des FOSA des districts sanitaire sur le dépistage et le prise en charge des maladies rénales (insuffisance rénale) ;
- Renforcement du plateau technique des FOSA des districts sanitaire ;

- Création des centres d'hémodialyse publics, d'accès équitable et régulation des centres de dialyse privés ;
- Renforcement du plateau technique des FOSA pour le diagnostic précoce des complications liées à l'insuffisance rénale ;
- Renforcement (quantitative et qualitative) des effectifs des ressources humaines du PNLIR et mobilisation du personnel impliqué à différents niveaux de la prise en charge ;
- Acquisition des médicaments pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique : Erythropoïétine ; Sevelamer, Fer injectable, Vaccins contre l'hépatite B et autres médicaments essentiels Génériques ;
- Mise en place d'un système de ravitaillements des centres de dialyse et de gestion des médicaments et consommables d'hémodialyse dans le pays.

- **Programme 3. Promotion de la santé rénale**

- Renforcement de la prévention de l'insuffisance rénale et de la promotion de santé rénale ;
- Mobilisation des responsables communautaires dans la prévention des facteurs de risque de l'insuffisance rénale.

- **Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et Recherche sur l'insuffisance rénale**

- Renforcement des capacités des acteurs sur la collecte des données factuelles sur l'insuffisance rénale ;
- Renforcement de la recherche opérationnelle sur l'insuffisance rénale ;
- Elaboration des outils de collecte de données et des indicateurs clés sur l'IR ;
- Mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation et d'un système de surveillance épidémiologie ;
- Elaboration d'un registre national de l'IR.

V. Cadre logique

Résultats attendus	Activités	Indicateurs de suivi/ performance	Source de vérification	Responsa-bles	Chronogramme					Budget	Source de finance-ment/ bailleurs
					2025	2026	2027	2028	2029	FCFA	
Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale											
Sous-programme1-1. Renforcement de la gouvernance, du leadership et du pilotage des activités du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale											
OS 1. Renforcer la gouvernance, le leadership et le pilotage des activités du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale au Congo											
Résultat attendu n°1 : au moins 70% des textes (lois, décrets, arrêtés, notes de services) réglementant la prise en charge de l'insuffisance rénale au Congo ainsi que des documents stratégiques, normatifs et procéduraux du PNLIR sont élaborés, validés et disponibles.	**A1.** Organiser un atelier pour l'élaboration et la validation des textes d'application du décret n°2019-225 Août 2019	Nombre de textes d'application du décret n°2019-225 août 2019 validés et disponibles.	La liste de présence, et rapports d'activités	MSP/UCPP /DPNLIR						**12 521 600**	Gouvernement (MSP)
	A2. Organiser des ateliers pour l'élaboration et la validation des documents normatifs du PNLIR (Directives nationales, guide de prise en charge de l'IR, Normes et procédures etc)	Nombre d'ateliers d'élaboration et de validation organisés ; Nombre documents normatifs du PNLIR validés et disponibles.	La liste de présence, et rapports d'activités	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**48 082 400**	Gouvernement (MSP)

	A3. Organiser un atelier d'élaboration et de validation des textes réglementaires de la dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale) au Congo	Nombre de textes réglementaires de la dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale) au Congo validés et disponibles.	La liste de présence, et rapports d'activités	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**12 579 200**	Gouvernement (MSP)
	A4. Organiser un atelier d'élaboration et de validation du plan de travail budgétisé (PTAB) une fois par an	Nombre d'ateliers organisés. Nombres de PTAB validés, disponibles et accessibles.	La liste de présence, et rapports d'activités	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**12 500 000**	Gouvernement (MSP)
	A5. Organiser un atelier d'évaluation à mi-parcours du PSN 2025-2029 de lutte contre l'IR au Congo	Score des indicateurs de performances réalisées.	La liste de présence, et rapports d'activités	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**15 134 000**	Gouvernement (MSP)
	A6. Organiser un atelier d'élaboration et de validation du PSN 2030-2034 de Lutte contre l'IR au Congo	Existence d'un PNS validé et disponible	La liste de présence, et rapports d'activités	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**22 520 000**	Gouvernement (MSP)
	A7. Tenir des réunions de coordination une fois par trimestre sur les interventions du PSN	Nombre de réunions tenues par an.	La liste de présence. Compte rendu des réunions.	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**0**	Gouvernement (MSP)

	A8. Organiser au moins une session de formation résidentiel de six (06) jours d'au moins 25 personnes pour le renforcement des capacités managériales (planification, suivi, supervision et évaluation), techniques et opérationnelles des équipes de coordination nationale et départementale du PNLIR.	Nombre de sessions de formation organisées. Proportion des personnes formées.	La liste de présence ; Rapport d'activité	MSP/UCPP /DPNLIR /FOSA						**17 116 000**	Gouvernement (MSP)
	A9. Faire un plaidoyer auprès du MSP pour l'acquissions d'un local et la dotation de deux (2) véhicules et deux (2) motos pour la coordination, la supervision et la surveillance épidémiologique.	Nombre de réunions organisées pour le plaidoyer ; Nombre des véhicules et motos et reçus ; Nombre de locaux acquis	La liste de présence. Compte rendu des réunions. PV de livraison ;	MSP/UCPP DPNLIR						**0**	Gouvernement (MSP)

Sous-programme1-2. Mobilisation des fonds et développement du partenariat											
OS 2. Mobiliser les fonds suffisants et durables pour la lutte contre l'insuffisance rénale et le développement du partenariat											
Résultat attendu n°2 : au moins 75 % des fonds indispensables à la mise en œuvre des interventions de lutte contre l'IR sont mobilisés.	**A10.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation du plan de mobilisation des ressources	Existence d'un plan de mobilisation des ressources validé et disponible.	La liste de présence. Rapports d'activités	MSP/UCPP DPNLIR						**10 000 000**	Gouvernement (MSP)
	A11. Faire un plaidoyer une fois par an auprès du Ministre de la santé et des parlementaires pour l'augmentation de 10% de la ligne budgétaire du PNLIR	Nombre de réunions de plaidoyer Organisées.. Taux d'augmentation du budget alloué au PNLIR.	La liste de présence. Compte rendu des réunions.	DPNLIR						**0**	Gouvernement (MSP)
Résultat attendu n°3 : au moins 25% des Organismes du Système des Nations Unies et d'autres partenaires et bailleurs collaborent avec le PNLIR au niveau national et international.	**A12.** Organiser des réunions de plaidoyer auprès des PTF (OMS, PNUD, FM...) pour le financement des interventions de lutte contre l'IR	Nombre de réunions de plaidoyer organisées. Nombre d'accord de partenariats signés.	Comptes rendus des réunions de plaidoyer.	MSP/UCPP DPNLIR						**1 434 000**	Gouvernement (MSP)
	A13. Organiser chaque année, des journées portes ouvertes avec les entreprises, les sociétés, les institutions ou structures privées menant les activités en lien avec les facteurs de risque de l'IR.	Nombre des journées organisées. Nombre de partenariats signés ;	Existence des accords de partenariat. Rapports d'activités.	MSP/UCPP DPNLIR						**1 981 000**	Gouvernement (MSP)

	A14. Organiser une réunion pour la signature d'une Convention spéciale de partenariat avec un Laboratoire (JANSSEN) pour la disponibilité de l'Erythropoïétine et Sevelamer	Nombre de partenariat signé ; Nombre de réunion organisée.	Procès-verbal /compte rendu de la réunion. Disponible des documents signés.	MSP/UCPP DPNLIR						**981 000**	Gouvernement (MSP)
	A15. Organiser une réunion avec les ONG/Associations menant les activités de lutte contre l'IR, pour la signature des accords de partenariat.	Nombre de réunions organisées. Nombre de partenariats signés.	Comptes rendus de la réunion. Disponible des documents signés.	MSP/UCPP DPNLIR						**2 696 000**	Gouvernement (MSP)
	A16. Organiser au moins deux réunions de concertation par an sur les interventions communes avec les autres programmes de santé (PNLHV, PEV...)	Nombre de réunions tenue.;	Compte rendu de la réunion ;	MSP/UCPP DPNLIR						**5 992 000**	Gouvernement (MSP)
Coût Programme1 :											**163 537 200**

Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR.											
OS 3. Renforcer l'offre de soins et des services de prise en charge de l'insuffisance rénale.											
Résultat attendu n° 4 : le dépistage et la prise en charge de l'insuffisance rénale sont intégrés dans les soins de santé primaires	**A17.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un plan d'intégration du dépistage et de prise en charge des maladies rénales dans les soins de santé primaire (SSP)	Nombre d'atelier organisé.; Existence d'un plan validé et accessibles.	Compte rendu ; PNLIR.	MSP/UCPP /DPNLIR						**1 400 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A18. Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer auprès du Ministre de la santé et de population pour l'intégration du dépistage et la prise en charge des maladies rénales dans les SSP	Nombre de réunions de plaidoyer organisés. Nombre de districts sanitaires ayant intégré les activités de dépistages et de prise en charge des maladies rénales.	Compte rendu des réunions de plaidoyer, Disponibilité des services de dépistage et de prise en charge dans les DS, HR et CSI.	MSP/UCPP /DPNLIR /District sanitaire / FOSA.						**0**	Gouvernement (MSP) et PTF
Résultat attendu n° 5 : L'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR sont intégrées et opérationnelles dans les DS.	**A19**. Organiser un atelier présentiel de (6) jours de 25 personnes pour l'élaboration et la validation des algorith-mes de dépistage et de prise en charge des maladies rénales.	Nombre d'ateliers d'élaboration et de validation organisés. Nombre des algorithmes validés et disponibles.	Rapport d'activité ; Disponibilité des algorithmes de dépistage et de prise en charge de l'IR dans les FOSA.	MSP/UCPP /DPNLIR/ District sanitaire (FOSA)						**12 496 000**	Gouvernement (MSP) et PTF

	A20. Organiser deux ateliers résidentiels de formation de cinq (05) jours, d'au moins 30 formateurs et 150 prestataires de soins des différents départements sur le dépistage et la prise en charge de l'IR.	Nombre de sessions de formation Organisées. Proportion des formateurs formés. Proportion des prestataires de soins formés par départements.	Rapport d'activité, La liste de présence	MSP/UCPP DPNLIR / District sanitaire (FOSA).						**67 798 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A21. Assurer la duplication et la dotation des algorithmes de dépistage et de prise en charge des maladies rénales dans les FOSA ainsi que des kits de dépistage et des soins.	Nombre des algorith-mes dupliqués et des FOSA doteés. Nombre de kits de dépistage et des soins	Rapport d'activité. Bon de livraison.	MSP/UCPP DPNLIR / CAMEPS/ District sanitaire (FOSA).						**58 794 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A22. Organiser une mission de supervision formative par trimestre auprès des prestataires de soins des FOSA sur le dépistage et prise en charge des maladies rénales.	Nombre de missions de supervisions organisées par an. Nombre des FOSA visitées. Nombre des personnes supervisées.	Rapport d'activité. Grille de supervision disponible. Liste de présence.	MSP/UCPP DPNLIR / District sanitaire (FOSA).						**36 788 000**	Gouvernement (MSP)

Résultat attendu n° 6 : au moins 20 néphrologues et 40 personnels soignants en dialyse sont formés et mis sur le terrain	**A23.** Organiser deux (02) réunions de plaidoyer auprès des MSP, METP et MES, pour l'ouverture d'une filière sur les soins de dialyse dans les écoles paramédicales	Nombre de réunions de plaidoyer organisée. Nombre d'écoles paramédicales ayant ouvert une filière sur les soins de dialyse.	.Rapport d'activité. Note ministé-rielle.	MSP/MES METP/ UCPP/ DPNLIR/						**620 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A24. Organiser deux ateliers résidentiels de formation de 20 jours, d'au moins 40 IDE des différents départements sur les soins en dialyse.	Nombre de sessions de formation organisées. Proportion des IDE formés dans les départements.	Rapport d'activité, La liste de présence. Attestations de formation	MSP/UCPP /DPNLIR/ FOSA						**36 325 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A25. Faire un plaidoyer auprès du Ministre de la santé et de la population, pour la formation de 10 néphrologues à l'étranger.	Nombre de réunions de plaidoyer organisées. Proportion des néphrologues formés à l'étranger	Compte rendu des réunions de plaidoyer. Disponibilités des attestations de fin de formation.	MSP/UCPP DPNLIR/ FOSA/						**1 000 000**	Gouvernement (MSP)
	A26. Faire un plaidoyer pour la formation d'au moins cinq (05) techniciens biomédicaux en dialyse à l'étranger (maintenance)	Nombre de réunions de plaidoyer Organisées. Proportion des techniciens biomédicaux formés à l'étrange sur la maintenance.	Compte rendu des réunions de plaidoyer. Attestation fin de formation.	MSP/UCPP DPNLIR/ FOSA						**250 000**	Gouvernement (MSP)

Résultat attendu n°7 : au moins 75% des hôpitaux généraux et 50% des hôpitaux de base disposent d'un service de néphrologie	**A27. Plaidoyer pour** la mise en place d'un service de néphrologie dans 15 hôpitaux généraux et de base.	Nombre d'hôpitaux H/G disposant d'un service de néphrologies fonctionnels	Compte rendu ; Hôpitaux B/G.	MSP						**3 000 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A28. Organiser au moins deux réunions de plaidoyer par an auprès du MSP et les parlementaires pour l'intégration d'une unité de dialyse péritonéale dans les services de pédiatrie des hôpitaux des départements	Nombre de réunions organisées ; Nombre d'hôpitaux disposant d'une unité de dialyse péritonéale dans le service de pédiatrie.	Compte rendu des réunions.	MSP/UCPP /DPNLIR/ HG/HR/CD						**1 579 200**	Gouvernement (MSP)
Résultat attendu n°8 : au moins deux (2) hôpitaux généraux à B/ville et P/N disposent d'un centre de dialyse intra-hospitalier construit, équipé et fonctionnel.	**A29.** Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer par an auprès du Ministre de la santé et de la population et les parlementaires pour la construction et l'équipement de deux (2) centres de dialyse extrahospitalier et deux (2) intra-hospitaliers à Brazzaville et Pointe/N	Nombre de réunions de plaidoyer organisées. Nombre de centres de dialyse extra et intra-hospitaliers construis, équipés et fonctionnels à Brazzaville et Pointe-Noire.	Compte rendu des réunions de plaidoyer. Existence de Centres de dialyses extra et intra hospitaliers construis et fonctionnel.	MSP/UCPP /DPNLIR/ FOSA						**1 056 000**	Gouvernement (MSP) et PTF

Résultat Attendu n°9 : au moins 75% des patients souffrant d'IRCT ont accès à la dialyse.	**A30.** Organiser au moins trois (03) réunions de plaidoyer par an auprès du Ministre de la santé et de population, les parlementaires et des PTF pour la gratuité de la dialyse au Congo	Nombre de réunions de plaidoyer organisées. Proportion de patients IRCT dialysés gratuitement.	Compte rendu de réunions de plaidoyer /rapport d'activité, La liste de présence.	MSP/UCPP /DPNLIR / FOSA /CD						**792 000**	Gouvernement (MSP)
OS 4. Améliorer l'accessibilité des patients aux soins et services de prise en charge de l'IR.											
Résultat attendu n°10 : au moins 75% de la gamme des produits de l'IR (l'érythro-poïétine, le fer injectable, Sevelamer et dapagliflozine) sont gratuits et disponibles.	**A31.** Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer pour la mise en place de la gratuité des médicaments de l'IR (l'érythropoïétine (EPO), fer injectable, Sevelamer et Dapagliflozine)	Nombre de réunions organisées. Nombre de médicaments de gratuité disponible.	Comptes rendus des réunions. La liste de présence.	MSP/UCPP DGSSSa/ CAMEPS/ PNLIR						**528 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A32. Organiser au moins (3) réunions de plaidoyer pour l'inscription des génériques de l'EPO, du Sevelamer et dapagliflozine sur la liste nationale des médicaments essentiels	Nombre de réunions de plaidoyers organisées. Nombre des médicaments essentiels inscrites.	Comptes rendus des réunions de plaidoyers ; La liste de présence ; La liste nationale des médicaments essentiels.	MSP/UCPP DGSSa/ DPM/ DPNLIR CAMEPS						**264 000**	Gouvernement (MSP) et PTF

	A33. Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer pour l'acquisition de l'EPO et du Sevelamer	Nombre de réunions de plaidoyers organisées ; Nombre de l'EPO et du Sevelamer.	Comptes rendus des réunions. La liste de présence.	MSP/ DGSSa/ DPM/ DPNLIR CAMEPS						**528 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
Résultat Attendu n°11: au moins 95% des patients souffrant d'IRCT sont immunisés contre l'hépatite B.	**A34.** Organiser au moins deux (02) réunions conjointes avec PEV, CD et le PNLHV sur la gratuité du vaccin contre l'hépatite B chez les patients dyalisés	Nombre de réunions conjointes organisées.	Comptes rendus des réunions. La liste de présence.	MSP/UCPP DPNLIR/ PNLHV/ PEV						**235 500**	Gouvernement (MSP)
	A35. Mettre sous prophylaxie systématique de l'hépatite B, tous les cas IRC en collaboration avec le PNLHV	Nombre de cas IRCT mis sous prophylaxie systématique de l'hépatite B.	Rapport d'activité.	MSP/UCPP DPNLIR / PEV/ CH/ PNLHV/						**18 000 000**	Gouvernement (MSP)
OS 5. Renforcer la collaboration avec la CAMEPS pour la gestion des médicaments et consommables de la dialyse.											
Résultat attendu n°12 : le PNLIR collabore avec la CAMEPS sur la gestion des médicaments et consommables de la dialyse et le	**A36.** Organiser au moins trois réunions avec la CAMEPS et les PTF, pour la mise en place d'une unité de gestion des médicaments et consommables de dialyse et de ravitaillement au sein du PNLIR	Nombre de réunions organisées. Existence d'une unité de gestion au PNLIR.	Comptes rendus des réunions. La liste de présence.	MSP/UCPP DPNLIR / CAMEPS/ CD						**264 000**	Gouvernement (MSP)

ravitaillement des départements de Brazzaville et Pointe-Noire.	**A37.** Organiser une réunion de coordination du PNLIR une fois par trimestre avec les autres structures (CD, PEV, CAMEPS ...) sur la gestion des médicaments et consommables de la dialyse et leur ravitaillement.	Nombre de réunions organisées. Taux de participation.	Comptes rendus des réunions de coordination. La liste de présence.	MSP/UCPP DPNLIR / CD						**264 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A38. Organiser un atelier de renforcement des capacités sur la gestion et le ravitaillement des consommables de la dialyse et médicaments	Nombre d'ateliers de formation organisés. Nombre des acteurs formés.	La liste de présence. Rapport d'activité.	MSP/UCPP /DPNLIR /CD						**8 090 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A 39. Ravitailler les centres de dialyse de façon régulière en consommables de dialyse et médicaments	Nombre de consommables et médicaments livrés. Nombre de ravitaillements effectués.	Rapport d'activité. La liste de présence.							**353000000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A40. Organiser une supervision formative par trimestre sur la gestion de médicaments consommables de la dialyse dans les centres de dialyse.	Nombre de supervisions formatives organisées. Nombre de CD supervisés.	Rapport d'activité. La liste de présence.	MSP/UCPP /DPNLIR /CD						**618 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
Coût Programme 2										**602 289 700**	

Programme 3. Promotion de la santé rénale											
OS 6. Renforcer la prévention de l'insuffisance rénale et la promotion de la santé rénale dans la population générale et à risque											
Résultat Attendu n°13 : au moins 70% de la population générale est sensibilisée sur les facteurs de risque de l'IR et 80% des IR sont détectés précocement et prise en charge.	**A41.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un plan de communication des relais communautaire et des prestataires des FOSA sur la promotion de la santé rénale.	Nombre d'ateliers organisés. Nombre de plans de communication élaborés et validés.	Rapport d'activité /Compte rendu ; La liste de présence.	MSP/UCPP /DDSSSa/ DPNLIR /CD						**28 350 000**	Gouvernement (MSP)
	A42. Organiser au moins un atelier de formation en présentiel de (04) quatre jours et de (60) relais communautaires pour la sensibilisation sur les facteurs de risque et la prévention des IR dans les DS.	Nombre de sessions de formation réalisées. Proportion des relais formées dans chaque district sanitaire.	Rapport d'activité. La liste de présence.	MSP/UCPP /DGSSSa/ DPNLIR/ District sanitaire,						**31 692 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A43. Organiser une campagne de sensibilisation de la population générale et à risque (à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein) sur les facteurs de risque de l'IR, le dépistage et la prise en charge des cas.	Nombre de campagnes de sensibilisation organisée par an. Proportion de la pop sensibilisée, proportion des personnes dépistées, malades et prise en charge.	Rapport d'activité.	SP.UCPP DPNLIR/ District sanitaire /FOSA						**91 292 000**	Gouvernement (MSP) et PTF

Résultat Attendu n°14 : au moins 80% des populations à risque d'IR (HTA, diabète sucré, obésité...) sont sensibilisées sur les maladies rénales et acquièrent un plus grand contrôle de leur propre santé et l'améliorent.	**A44.** Organiser une campagne de sensibilisation une fois par an, sur les facteurs de risque et les mesures de prévention de l'IR, dans les milieux scolaires et professionnels	Proportion des personnes sensibilisées.	Rapport d'activité.	MSP/ DGPop/ PNLIR METP/ MEPSA						**50 020 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A45. Organiser une campagne de sensibilisation de la population générale et à risque une fois par an sur les facteurs de risque, le dépistage et la prise en charge de l'IR, à l'occasion de la Journée Mondiale du diabète.	Proportion des personnes sensibilisées.	Rapport d'activité ; La liste de personnes sensibilisées.	MSP/UCPP DPNLIR/ District sanitaire /FOSA/ DELM						**77 299 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A46. Organiser une campagne de sensibilisation une fois par an sur les facteurs de risque, le dépistage et la prise en de l'IR à l'occasion de la Journée Mondiale de l'HTA en collaboration avec la Société Congolaise de Cardiologie.	Proportion des personnes sensibilisées.	Rapport d'activité. La liste de personnes sensibilisées.	MSP/UCPP DPNLIR/ District sanitaire /FOSA/ DELM						**38 099 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
Coût Programme 3 :										**31 6752 000**	

Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale											
OS 7. Mettre en place un système de surveillance épidémiologique et de gestion de données sur l'insuffisance rénale											
Résultat Attendu n°15 : les outils de collecte de données et les indicateurs de surveillance épidémiologique de l'IR sont disponibles et paramétrés dans le. DHIS2.	**A47.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation (adaptation) des outils de collecte de données de l'IR et le registre national de l'IR au Congo	Nombre d'outils de collecte validés et disponibles. Existence d'un registre national sur l'IR.	Rapport d'activité ; La liste de présence.	MSP/UCPP /DPNLIR/ DISER,/ DELM						**10 988 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A48. Organiser un atelier de paramétrage des outils de collecte et des indicateurs de surveillance de l'IR dans le DHIS2	Disponibles des outils de collecte dans DHIS2.	Rapport d'activité ; La liste de présence ;	MSP/UCPP /DPNLIR /DISER						**52 230 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A49. Organiser trois ateliers de formation des points focaux départementaux et des agents de santé (CSI/ HR/HG/DS) sur la collecte de données et leur enregistrement dans le DHIS2 et la rédaction des rapports de surveillance de l'IR	Nombre de sessions de formation organisées. Proportion de points focaux et des agents de santé (CSI, HB/HG et DS) formés.	Rapport d'activité. La liste de présence.	MSP/UCPP /DPNLIR						**52 230 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A50. Dupliquer et doter les FOSA en outils de collecte de données	Nombre FOSA dotés en outils de collecte de données.	Rapport d'activité. PV de livraison	MSP/UCPP /DPNLIR.						**13 796 000**	Gouvernement (MSP) et PTF

Résultat Attendu n°16 : Un système résilient de surveillance de l'IR (cas et décès) est développé au PNLIR	**A51.** Organiser des missions de supervision formatives une fois par trimestre sur la qualité des données des FOSA	Nombre de missions de supervisions organisées. Nombre de FOSA supervisées.	Rapport d'activité. Grille de supervision	MSP/UCPP /DPNLIR/ DISER/DS/ FOSA						**47 880 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A52. Organiser un atelier en présentiel pour l'élaboration et la validation du guide de surveillance épidémio-logique de l'IR	Nombre d'ateliers résidentiel organisés. Existence d'un guide de surveillance épidémiologique de l'IR validé.	Rapport d'activité. La liste de présence.	MSP/UCPP /DPNLIR/ DISER/ DELM						**135 340000**	Gouvernement (MSP) et PTF
OS 8. Promouvoir la recherche opérationnelle sur l'IR											
Résultat Attendu n°17 : Les bases factuelles issues de la recherche sur l'IR sont disponibles	**A53**. Organiser une journée scientifique de néphrologie une fois par an, en collaboration avec la Société Congo-laise de Néphrologie.	Nombre de journées scientifiques organisées	Comptes rendus de la réunion	MSP/UCPP /DPNLIR/ SCN						**3 808 000**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A54. Organiser une étude STEP/CAP sur les facteurs de risque de l'IR, l'accès aux médicaments de l'IR et à la dialyse une fois par an au niveau national.	Nombre d'études STEP/CAP réalisées.	Rapport d'enquête.	SP/UCPP DPNLIR						**54 789 500**	Gouvernement (MSP) et PTF
	A55. Proposer chaque année 2 thèmes de recherche sur l'IR aux étudiants en science de la santé finalistes.	Nombre d'études réalisées sous couvert du PNLIR.	Rapport d'étude.	DPNLIR						**2 500 000**	Gouvernement (MSP)
Coût Programme 4 :										**373 561 500**	

VI. Plan de financement

Le présent plan de financement donne la répartition des coûts par programme et par activité durant la période de mise en œuvre du PSN 2025-2029.

Résultats attendus	Activités	Chronogramme					Budget
		2025	2026	2027	2028	2029	FCFA
Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte **contre l'Insuffisance Rénale**							
Sous-programme1-1. Renforcement de la gouvernance, du leadership et du pilotage des activités du Programme National de la Lutte contre l'Insuffisance Rénale							
OS 1. Renforcer la gouvernance, le leadership et le pilotage des activités du Programme National de lutte contre l'insuffisance rénale au Congo.							
Résultat attendu n°1 : au moins 70% des textes (lois, décrets, arrêtés, notes de services) réglementant la prise en charge de l'insuffisance rénale au Congo ainsi que des documents stratégiques, normatifs et procéduraux du PNLIR sont élaborés, validés et disponibles.	**A1.** Organiser un atelier pour l'élaboration et la validation des textes d'application du décret n°2019-225 Août 2019	0	6 260 800	6 260 800	0	0	**12 521 600**
	A2. Organiser des ateliers pour l'élaboration et la validation des documents normatifs du PNLIR (Directives nationales, guide de prise en charge de l'IR, Normes et procédures etc)	9 616 480	9 616 480	9 616 480	9 616 480	9 616 480	**48 082 400**
	A3. Organiser un atelier d'élaboration et de validation des textes réglementaires de la dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale) au Congo	0	6 289 6006	6 289 600	0	0	**12 579 200**

	A4. Organiser un atelier d'élaboration et de validation du plan de travail budgétisé (PTAB) une fois par an	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**12 500 000**
	A5. Organiser un atelier d'évaluation à mi-parcours du PSN 2025-2029 de lutte contre l'IR au Congo	0	0	15 134 000	0	0	**15 134 000**
	A6. Organiser un atelier d'élaboration et de validation du PSN 2030-2034 de Lutte contre l'IR au Congo	0	0	0	0	22 520 000	**22 520 000**
	A7. Tenir des réunions de coordination une fois par trimestre sur les interventions du PSN	0	0	0	0	0	**0**
	A8. Organiser au moins une session de formation résidentiel de six (06) jours d'au moins 25 personnes pour le renforcement des capacités managériales (planification, suivi, supervision et évaluation), techniques et opérationnelles des équipes de coordination nationale et départementale du PNLIR.	0	0	17 116 000	0	0	**17 116 000**
	A9. Faire un plaidoyer auprès du MSP pour l'acquissions d'un local et la dotation de deux (2) véhicules et deux (2) motos pour la coordination, la supervision et la surveillance épidémiologique.	0	0	0	0	0	**0**

Sous-programme1-2. Mobilisation des fonds et développement du partenariat.							
OS 2. Mobiliser les fonds suffisants et durables pour la lutte contre l'insuffisance rénale et le développement du partenariat .							
Résultat attendu n°2 : au moins 75 % des fonds indispensables à la mise en œuvre des interventions de lutte contre l'IR sont mobilisés.	**A10.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation du plan de mobilisation des ressources	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**10 000 000**
	A11. Faire un plaidoyer une fois par an auprès du Ministre de la santé et des parlementaires pour l'augmentation de 10% de la ligne budgétaire du PNLIR	0	00	0	0	0	**0**
Résultat attendu n°3 : au moins 25% des Organismes du Système des Nations Unies et d'autres partenaires et bailleurs collaborent avec le PNLIR au niveau national et international.	**A12.** Organiser des réunions de plaidoyer auprès des PTF (OMS, PNUD, FM...) pour le financement des interventions de lutte contre l'IR	0	358 500	358 500	358500	3585000	**1 434 000**
	A13. Organiser chaque année, des journées portes ouvertes avec les entreprises, les sociétés, les institutions ou structures privées menant les activités en lien avec les facteurs de risque de l'IR.	396 200	396 200	396 200	396 200	396 200	**1 981 000**
	A14. Organiser une réunion pour la signature d'une Convention spéciale de partenariat avec un Laboratoire (JANSSEN) pour la disponibilité de l'Erythropoïétine et Sevelamer	0	490 5000	490 5000	0	0	**981 000**

	A15. Organiser une réunion avec les ONG/Associations menant les activités de lutte contre l'IR, pour la signature des accords de partenariat.	0	0	2 696 000	0	0	**2 696 000**
	A16. Organiser au moins deux réunions de concertation par an sur les interventions communes ave les autres programmes de santé (PNLHV, PEV..)	1 198 400	1 198 400	1 198 400	1 198 400	1 198 400	**5 992 000**
Coût Programme1 :		**13 711 080**	**29 610 480**	**64 556 480**	**16 569 580**	**39 089 580**	**163 537 200**
Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR							
OS 3. Renforcer l'offre de soins et des services de prise en charge de l'insuffisance rénale							
Résultat attendu n° 4 : le dépistage et la prise en charge de l'insuffisance rénale sont intégrés dans les soins de santé primaires	**A17.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un plan d'intégration du dépistage et de prise en charge des maladies rénales dans les soins de santé primaire (SSP)	700 000	700 000	0	0	0	**1 400 000**
	A18. Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer auprès du Ministre de la santé et de population pour l'intégration du dépistage et la prise en charge des maladies rénales dans les SSP	0	0	0	0	0	**0**
Résultat attendu n° 5 : L'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR sont intégrées et opérationnelles dans les DS.	**A19.** Organiser un atelier présentiel de (6) jours de 25 personnes pour l'élaboration et la validation des algorithmes de dépistage et de prise en charge des maladies rénales.	0	6 248 000	6 248 000	0	0	**12 496 000**

Résultat attendu n° 6 : au moins 20 néphrologues et 40 personnels soignants en dialyse sont formés et mis sur le terrain	**A20.** Organiser deux ateliers résidentiels de formation de cinq (05) jours, d'au moins 30 formateurs et 150 prestataires de soins des différents départements sur le dépistage et la prise en charge de l'IR.	0	33 899 000	33 899 000	0	0	**67 798 000**
	A21. Assurer la duplication et la dotation des algorithmes de dépistage et de prise en charge des maladies rénales dans les FOSA ainsi que des kits de dépistage et des soins.	0	29 397 000	29 397 000	0	0	**58 794 000**
	A22. Organiser une mission de supervision formative par trimestre auprès des prestataires de soins des FOSA sur le dépistage et prise en charge des maladies rénales.	0	9 197 000	9 197 000	9 197 000	9 197 000	**36 788 000**
	A23. Organiser deux (02) réunions de plaidoyer auprès de MSP/METP/MES, pour l'ouverture d'une filière sur les soins de dialyse dans les écoles de santé	0	0	310 000	310 000	0	**620 000**
Résultat attendu n°7 : au moins 75% des hôpitaux généraux et 50% des hôpitaux de base disposent d'un service de néphrologie.	**A24.** Organiser deux ateliers résidentiels de formation de 20 jours, d'au moins 40 IDE des différents départements sur les soins en dialyse.	0	0	18 162 500	18 162 500	0	**36 325 000**
	A25. Faire un plaidoyer auprès du Ministre de la santé et de la population, pour la formation de 10 néphrologues à l'étranger.	0	500 000	500 000	0	0	1 000 000
	A26. Faire un plaidoyer pour la formation d'au moins cinq (05) techniciens biomédicaux en dialyse à l'étranger (maintenance).	0	125 000	125 000	0	0	**250 000**

	A27. Plaidoyer pour la mise en place d'un service de néphrologie dans 15 hôpitaux généraux et de base.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**3 000 000**
Résultat attendu n°8 : au moins deux (2) hôpitaux généraux à B/ville et P/N disposent d'un centre de dialyse intra-hospitalier construit, équipé et fonctionnel.	**A28.** Organiser au moins deux réunions de plaidoyer par an auprès du MSP et les parlementaires pour l'intégration d'une unité de dialyse péritonéale dans les services de pédiatrie des hôpitaux des départements	0	526 400	526 400	526 400	0	**1 579 200**
	A29. Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer par an auprès du Ministre de la santé et de la population et les parlementaires pour la construction et l'équipement de deux (2) centres de dialyse extrahospitalier et deux (2) intra-hospitaliers à Brazzaville et Pointe-Noire.	0	352 000	352 000	352 000	0	**1 056 000**
Résultat Attendu n°9 : au moins 75% des patients souffrant d'IRCT ont accès à la dialyse.	**A30.** Organiser au moins trois (03) réunions de plaidoyer par an auprès du Ministre de la santé et de population, les parlementaires et des PTF pour la gratuité de la dialyse au Congo.	0	0	396 000	396 000	**0**	**792 000**
OS 4. Améliorer l'accessibilité des produits médicaux de l'IR aux patients							
Résultat attendu n°10 : au moins 75% de la gamme des produits de l'IR (l'érythro-poïétine, le fer injectable, Sevelamer et dapagliflozine) sont gratuits et disponibles.	**A31.** Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer pour la mise en place de la gratuité des médicaments de l'IR (l'érythropoïétine (EPO), fer injectable, Sevelamer et Dapagliflozine).	0	264 000	264 000	0	0	**528 000**

	A32. Organiser au moins (3) réunions de plaidoyer pour l'inscription des génériques de l'EPO, du Sevelamer et dapagliflozine sur la liste nationale des médicaments essentiels.	0	0	264 000	0	0	**264 000**
	A33. Organiser au moins deux (02) réunions de plaidoyer pour l'acquisition de l'EPO et du Sevelamer	0	0	528 000	0	0	**528 000**
Résultat Attendu n°11 ; au moins 95% des patients souffrant d'IRCT sont immunisés contre l'hépatite B.	**A34**- Organiser au moins deux (02) réunions conjointes avec le PEV, CD et le PNLHV sur la gratuité du vaccin contre l'hépatite B chez les patients dyalisés.	0	117 750	117 750	0	0	**235 500**
	A35- Mettre sous prophylaxie systématique de l'hépatite B, tous les cas IRC en collaboration avec le PNLHV	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	**18 000 000**
OS 5. Renforcer la collaboration avec la CAMEPS pour la gestion des médicaments et consommables de la dialyse.							
Résultat attendu n°12: le PNLIR collabore avec la CAMEPS sur la gestion des médicaments et consommables de la dialyse et le ravitaille-ment des départements de Brazzaville et Pointe-Noire.	**A36.** Organiser au moins trois réunions avec la CAMEPS et les PTF, pour la mise en place d'une unité de gestion des médica-ments et consomma-bles de dialyse et de ravitaillement au sein du PNLIR	0	0	264 000	0	0	**264 000**
	A37. Organiser une réunion de coordina-tion du PNLIR une fois par trimestre avec les autres structures (CD, PEV, CAMEPS ...) sur la gestion des médica- ments et consomma-bles de la dialyse et leur ravitaillement.	0	66 000	66 000	66 000	66 000	**264 000**

	A38. Organiser un atelier de renforcement des capacités sur la gestion et le ravitaillement des consommables de la dialyse et médicaments	0	8 090 000	0	0	0	**8 090 000**
	A 39. Ravitailler les centres de dialyse de façon régulière en consommables de dialyse et médicaments	0	88 250 000	88 250 000	88 250 000	88 250 000	**353000000**
	A40. Organiser une supervision formative par trimestre sur la gestion de médicaments consommables de la dialyse dans les centres de dialyse.	0	0	206 000	206 000	206 000	**618 000**
Coût Programme 2 :		**700 000**	**182 232 150**	**194 572 650**	**122 965 900**	**103 219 000**	**602 289 700**
Programme 3. Promotion de la santé rénale							
OS 6. Renforcer la prévention de l'insuffisance rénale et la promotion de la santé rénale dans la population générale et à risque.							
Résultat Attendu n°13 : au moins 70% de la population générale est sensibilisée sur les facteurs de risque de l'IR et 80% des IR sont détectés précocement et prise en charge.	**A41.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un plan de communication des relais communautaire et des prestataires des FOSA sur la promo-tion de la santé rénale.	0	28 350 000	0	0	0	**28 350 000**
	A42. Organiser au moins un atelier de formation en présentiel de (04) quatre jours et de (60) relais communautaires pour la sensibilisation sur les facteurs de risque et la prévention des IR dans les DS.	0	31 692 000	0	0	0	**31 692 000**

Résultat Attendu n°14 : au moins 80% des populations à risque d'IR (HTA, diabète sucré, obésité...) sont sensibilisées sur les maladies rénales et acquièrent un plus grand contrôle de leur propre santé et l'améliorent.	**A43.** Organiser une campagne de sensibilisation de la population générale et à risque (à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein) sur les facteurs de risque de l'IR, le dépistage et la prise en charge des cas.	0	22 823 000	22 823 000	22 823 000	22 823 000	**91 292 000**
	A44. Organiser une campagne de sensibilisation une fois par an, sur les facteurs de risque et les mesures de prévention de l'IR, dans les milieux scolaires et professionnels	0	12 505 000	12 505 000	12 505 000	12 505 000	**50 020 000**
	A45. Organiser une campagne de sensibilisation de la population générale et à risque une fois par an sur les facteurs de risque, le dépistage et la prise en charge de l'IR, à l'occasion de la Journée Mondiale du diabète.	15 459 800	15 459 800	15 459 800	15 459 800	15 459 800	**77 299 000**
	A46. Organiser une campagne de sensibilisation une fois par an sur les facteurs de risque, le dépistage et la prise en de l'IR à l'occasion de la Journée Mondiale de l'HTA en collaboration avec la Société Congo-laise de Cardiologie.	7 619 800	7 619 800	7 619 800	7 619 800	7 619 800	**38 099 000**
Coût Programme 3 :		23079 600	118 449 600	58 407 600	58 407 600	58 407 600	**31 6752 000**

Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale							
OS 7. Mettre en place un système de surveillance épidémiologique et de gestion de données sur l'insuffisance rénale							
Résultat Attendu n°15 : les outils de collecte de données et les indicateurs de surveillance épidémiologique de l'IR sont disponibles et paramétrés dans le. DHIS2.	**A47.** Organiser un atelier d'élaboration et de validation (adaptation) des outils de collecte de données de l'IR et le registre national de l'IR au Congo	10 988 000	0	0	0	0	**10 988 000**
	A48. Organiser un atelier de paramétrage des outils de collecte et des indicateurs de surveillance de l'IR dans le DHIS2	52 230 000	0	0	0	0	**52 230 000**
	A49. Organiser trois ateliers de formation des points focaux départementaux et des agents de santé (CSI/ HR/HG/DS) sur la collecte de données et leur enregistrement dans le DHIS2 et la rédaction des rapports de surveillance de l'IR	0	26 115 000	26 115 000	0	0	**52 230 000**
	A50. Dupliquer et doter les FOSA en outils de collecte de données.	0	13 796 000	0	0	0	**13 796 000**
Résultat Attendu n°16 : un système résilient de surveillance de l'IR (cas et décès) est développé au PNLIR	**A51.** Organiser des missions de supervision formatives une fois par trimestre sur la qualité des données des FOSA.	0	11 970 000	11 970 000	11 970 000	11 970 000	**47 880 000**
	A52. Organiser un atelier en présentiel pour l'élaboration et la validation du guide de surveillance épidémiologique de l'IR.	0	0	135 340 000	0	0	**135 340 000**

OS 8. Promouvoir la recherche opérationnelle sur l'IR							
Résultat Attendu n°17 : les bases factuelles issues de la recherche sur l'IR sont disponibles.	**A53.** Organiser une journée scientifique de néphrologie une fois par an, en collaboration avec la Société Congolaise de Néphrologie.	0	952 000	952 000	952 000	952 000	**3 808 000**
	A54. Organiser une étude STEP/CAP sur les facteurs de risque de l'IR, l'accès aux médicaments de l'IR et à la dialyse une fois par an au niveau national.	0	0	54 789 500	0	0	**54 789 500**
	A55. Proposer chaque année 2 thèmes de recherche sur l'IR aux étudiants en science de la santé finalistes.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	**2 500 000**
Coût Programme 4 :		**63718000**	**53333 000**	**229 666 500**	**13 422 000**	**13 422 000**	**373 561 500**

Synthèse budgétaire par programme

Axes	Coûts (FCFA) / année					Budget Total	Taux en %	Apport de l'Etat (80%)	Apport des PTF et donateurs (20%)
	2025	2026	2027	2028	2029				
Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale	13 711 080	29 610 480	64 556 480	16 569 580	39 089 580	163 537 200	**11,22**	130 829 760	32 707 440
Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR	700 000	182 232 150	194 572 650	122 965 900	103 219 000	603 689 700	**41,42**	482 951 760	120 737 940
Programme 3. Promotion de la santé rénale	23 079 600	118 449 600	58 407 600	58 407 600	58 407 600	316 752 000	**21,73**	253 401 600	63 350 400
Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale	63 718 000	53 333 000	229 666 500	13 422 000	13 422 000	373 561 500	**25,63**	298 849 200	74 712 300
Total par année	**101 208 680**	**383 625 230**	**547 203 230**	**211 365 080**	**214 138 180**	**1 457 540 400**	**100**	**1 166 032 320**	**291 508 080**

Source de financement

- Gouvernement : 80%, soit **1 166 032 320 FCFA.**
- Partenaires techniques, financiers et autres : 20%, soit **291 508 080 FCFA.**

Soit un coût global de la mise en œuvre du PSN 2025 – 2029 de lutte contre l'insuffisance rénale estimé à **1 457 540 400 FCFA.**

VII. Cadre de mise en œuvre

Le cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre est organisé selon les trois niveaux hiérarchiques décrits ci-dessous. Le PNLIR définit les politiques nationales, les lignes directrices et les grandes orientations stratégiques de lutte contre l'insuffisance rénale. Le responsable du Département de Suivi et Evaluation du PNLIR assurera en collaboration avec les autres Départements, sous la coordination du Directeur du programme, le pilotage des activités et le suivi des indicateurs de performances. Les Directions Départementales des Soins et Services de Santé veilleront à l'application des politiques et directives définies au niveau intermédiaire, ainsi qu'à la mise en œuvre des activités de lutte contre l'insuffisance rénale au niveau périphérique.

VII.1 Niveau central

Le niveau central définie les politiques nationales et les stratégies de mise en œuvre. Il élabore les documents stratégiques et normatifs nationaux sur la lutte contre l'insuffisance rénale, planifie les activités et oriente le pilotage des interventions au niveau intermédiaire et périphérique. Il vient en appui des différents acteurs (relevant du secteur public et privé) dans l'application des directives nationales et des stratégies définies. Il assure également la coordination, le pilotage, la supervision le suivi et l'évaluation de toutes les interventions menées.

VII.2 Niveau intermédiaire

Les Directions Départementales des Soins et Services de Santé (DDSSSa) sont des organes de coordination de la mise en œuvre au niveau intermédiaire. Pour cela, elles travailleront en collaboration avec les représentants des différentes structures et secteurs connexes, présents dans les départements. A ce titre, elles veilleront à ce que les activités de lutte contre l'insuffisance rénale soient intégrées dans les plans d'actions annuelles des districts sanitaires et des hôpitaux conformément aux directives du niveau central. Les DDSSSa évalueront également les performances réalisées au niveau intermédiaire et proposeront des solutions aux problèmes qui pourraient entraver la mise en œuvre de ces plans.

VII.3 Niveau périphérique

Les Districts Sanitaires constituent les unités de base pour la planification opérationnelle, la mise en œuvre des activités et l'évaluation. Pour cela, ils auront la responsabilité de travailler avec l'implication de toutes les parties prenantes, dans l'exécution de leurs plans d'actions.

VIII. Cadre de suivi et évaluation

Pour un suivi et une évaluation efficace, une équipe de coordination du niveau national, intermédiaire et périphérique doit être définie. Pour garantir la qualité de données et la fiabilité des résultats, les documents suivants serviront de base pour la collecte de données :

- Les outils de collecte et les rapports de surveillance épidémiologique (SIMR) ;
- Les rapports de CHEMU ;
- Les rapports mensuels et trimestriels des activités des formations sanitaires publiques et privées (HG ; HR, CSI, clinique, etc.) ;
- Les registres de consultation externe et de gestion des malades ;
- Le registre des patients sous dialyse ;
- Le registre de l'insuffisance rénale et des décès.

Un plan détaillé sur le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du PSN 2025-2029 sera élaboré. Ce plan aura pour objectif de (d') :

- Préciser l'organisation, le fonctionnement des acteurs ainsi que leurs rôles et niveaux de responsabilités ;
- Définir les mécanismes de suivi et évaluation du plan.
- Définir les indicateurs pour le suivi et évaluation du plan ;
- Préciser le circuit de production et de diffusion de l'information sanitaire pour la prise de décisions ;
- Identifier les sources d'informations pour le suivi et 'évaluation du plan.

- **Le suivi**

Les activités de suivi porteront sur :

- Les intrants de nature matérielle, financière, humaine et technique ;
- Le processus, notamment sur les activités du cadre logique ;
- Les extrants ou les produits, c'est-à-dire les résultats obtenus ;
- Le suivi et le calcul des indicateurs.

- **Evaluation**

L'évaluation portera sur le processus, les résultats et l'impact des interventions mises en œuvre. Une revue à mi-parcours du PSN sera organisée pour évaluer les performances réalisées, ajuster les écarts et améliorer la mise en œuvre et une revue finale pour mesurer les progrès accomplis.

IX. Indicateurs de suivi et d'évaluation

L'atteinte des objectifs fixés dans le PSN 2025-2029 dépendra de l'efficacité des stratégies développées et mise en œuvre à différents niveaux.

Les indicateurs de suivi des activités et des résultats sont définis dans ce plan.

Indicateurs	Niveau de performance															Observation	Décision
	2025			2026			2027			2028			2029				
	Cibles /attendues	Observés/ réalisés	écarts	Cibles /attendues	Observés/ réalisés	écarts	Cibles /attendues	Observés/ réalisés	écarts	Cibles /attendues	Observés/	écarts	Cibles /attendues	Observés/attendues	écarts		
Nombre/proportion de réunions organisées/tenues	5			10			15			20			25				
Nombre / proportion d'ateliers organisées	5			8			15			20			25				
Nombre /Proportion de districts sanitaires intégrés les activités dépistage et le prise en charge de la maladie rénale (IR)	0			10			20			30			45				
Nombre /Proportion de FOSA effectuant les activités de dépistage et de prise en charge des maladies rénales (IR).	0			25%			50%			75%			100%				
Nombre /Proportion de relais communautaires effectuant les activités de sensibilisation, de promo-tion de la santé rénale et de prévention de l'IR.	0			30			40			50			100				

Proportion d'IRT mis sous prophylaxie systématique de l'hépatite B	70%			85%			95%			95%			95%				
Proportion de la population générale sensibilisée sur IR	25%			50%			70%			70%			70%				
Proportion de la population à risque sensibilisée sur l'IR	25%			50%			75%			80%			80%				
Proportion de la population générale dépistée	15%			25%			50%			70%			80%				
Proportion de la population à risque dépistée (HTA ,diabète sucre, l'IR…) dans les FOSA.	25%			50%			650%			75%			85%				
Prévalence du diabète sucré, HTA, obésité, tabagisme, alcoolisme….	15%			20%			25%			50%			70%				
Nombre /Proportion de nouveaux cas d'IR	15%			20%			50%			75%			80%				
Prévalence de l'IR	15%			20%			40%			60%			70%				
Proportion des IRCT dialysés	50%			70%			80%			90%			95%				
Taux d'accès à la dialyse ou à l'hémodialyse.	25%			50%			75%			90%			95%				
Taux d'accessibilités à L'érythropoïétine , le fer injectable et Sevelamer	10%			15%			25%			50%			75%				
Taux de mortalité	15%			20%			30%			40%			50%				

X. Facteurs de risque, de succès (éléments de pérennité du plan)

X.1 Risques d'échec

Les risques d'échec identifiés sont les suivants **:**

- Mauvaise coordination ;
- Cadre juridique inadapté,
- Manque de financement et d'autres ressources,
- Insuffisance de ressources humaines formées à la prise en charge de l'insuffisance rénale
- Non mobilisation de la communauté,
- Non appropriation des interventions de PNLIR par les institutions et structures impliquées dans le renforcement de la gouvernance, le leadership et le pilotage des interventions de lutte contre l'insuffisance rénale ;
- Instabilité socio-politique et économique ;
- Faible pouvoir d'achat des populations ;
- Instabilité de personnel qualifié et fuite de cerveau ;
- Défaillance du système de gestion des MEG et des produits de santé pour l'insuffisance rénale ;
- Non décaissement de la contrepartie financière de l'État dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre l'insuffisance rénale ;
- Insuffisance de financement pour la recherche sur la maladie rénale chronique ; résistance au changement ;
- Faible couverture médiatique et capacité logistique pour la promotion de la santé rénale.

X.1 Facteur de succès

- Bonne gouvernance du secteur de la santé et des secteurs connexes ;
- Bonne volonté politique ;
- Stabilité de la paix et la sécurité.

CONCLUSION

Le présent Plan Stratégique National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale définit les orientations stratégiques, les priorités nationales et les principaux domaines d'intervention pour la lutte contre l'insuffisance rénale. Les stratégies contenues dans ce plan seront mises en œuvre au niveau national avec l'implication de toutes les parties prenantes afin de contribuer à l'atteinte de l'ODD3-4 sur la réduction d'un tiers de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissible dont l'insuffisance rénale à l'horizon 2030. Pour y parvenir, de nombreux défis restent à relever à travers les actions suivantes : (i) l'intégration du dépistage et de la prise en charge des maladies rénales dans le PMA et PCA des FOSA, (ii) la création des centres publics intra et extra hospitaliers de dialyse, (iii) la gratuité des érythropoïétines, du fer injectable, de Sevelamer et de la dialyse, (iv) l'inscription et l'acquisition des génériques de l'EPO, du Sevelamer et Dapagliflozines sur la liste nationale des médicaments essentiels, (v) la prévention des maladies rénales et la promotion de la santé rénale.

Ainsi, un engagement politique accompagné d'un investissement suffisant et durable associé à une coordination forte à tous les niveaux sont cruciaux pour une lutte efficace contre l'insuffisance rénale au Congo.

Références

1. National Institutes of Health. NI of D and D and KD US. Renal Data System. 2006.
2. National Kidney Foundation. K/DOQI. Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease : Evaluation, Clasification and Stratification (Internet). American Journal of Kidney Diseases.2002 ; S1-S266 p
3. Ouattara B, Kra O, Diby K, Thot'o As, Ouattara I Nn. Insuffisance rénale chronique chez l'adulte au CHU de Bouaké. Afr Biomed. 2004 ; 9(7) : 66-70.
4. Diouf B, Niang a, Ka EHF, Badiane M, Moreira Diop T. Chronical renal failure in one Dakar Hospital Department. Dakar Med. 2003; 48(3) :185-8.
5. Benja Ramilitiana1, Eliane Mikkelsen Ranivoharisoa1, Mihary Dodo1 and al. A retrospective study on the incidence of chronic renal failure in the Department of Internal Medicine and Nephrology at University Hospital of Antananarivo (the capital city of Madagascar). Pan African. Medical Journal. 2016 ; 23 :1418
6. Ouattara B, Kra O, Diby K, Thot'o As, Ouattara I Nn. Particularités de l'insuffisance rénale chronique chez des patients adultes noirs hospitalisés dans le service de médecine interne du CHU de Treichville. Afr Biomed. 2004 ;9(7):6670.
7. Kimbally-Kaky G, Gombet T, Bolanda JD, Voumbo Y, Okili B, Ellenga-Mbolla B. Prévalence de l'hypertension artérielle à Brazzaville. Cardiologie Tropicale. 2006 ; 32 : 43-46.
8. Eyeni Sinomono DT et al. Insuffisance rénale chronique au CHU de Brazzaville, Health Sciences and Disease 2021
9. Eyeni et al. Analyse Descriptive de la Population des Hémodialysés Chroniques au Congo-Brazzaville. Health Sci. Dis : Vol 22 (5) May 2021 pp 57-62
10. Eyeni et al.Profil Epidémiologique de l'insuffisance rénale chronique à Brazzaville en 2016. Néphrologie & Thérapeutique.13 (3):396

Annexe

Participants aux travaux d'élaboration, de relecture et de validation PSN 2025-2026

COORDINATION

- KITEMBO Lambert — Coordonnateur /UCPP
- EYENI SINOMONO Tony Daniel — Directeur du programme/PNLIR

APPUI TECHNIQUE

DUKUZIMANA Rodrigue	Consultant(SP)
MBOUITY Fred Davy	Consultant (SP)

N⁰	Noms et prénoms	Fonction/ Institution
1	NKALOU TICHICK Franchel Loïc	IDE /CTIR
2	NYANGA OPA Jolien Emony	Chef de département de prévention et prise en charge thérapeutique /PNLIR
3	NKOUNKOU MILANDO Ronce Derlan Bonheur	Pharmacien/CHU-B
4	MOUSSOUNDA MBOUNGOU Beltran	Collaborateur /PNLIR
5	POATY MAVOUNGOU Ange	Chef du bureau / PNLIR
6	MOUSSAVOU MBONZI Zita	Adjoint du responsable administrative financier comptable /PNLIR
7	MONKA YOULOU Léger Miche	Responsable suivi évaluation /UCPP
8	MVOUNGOU ONDOUMA Princia	Collaboratrice /PNLIR
9	MONKA YOULOU Léger Michel	Responsable suivi évaluation /UCPP
10	NGOMA CETI Merril Précieux	Médecin généraliste / CHU
11	BOUMPOUTOU Filbert	Technicien biomédicale / CTIR
12	BOUITY MAVET Richel Biagnef	IDE /CTIR
13	ETITI Fridolin	Responsable administrative financier comptable /PNLIR

EPUPE D'ELABORATION

EQUIPE DE RELECTURE

N^0	**Noms et prénoms**	**Fonction/ Institution**
1	MOBOUSSE MIESSE Jean Claude	Conseiller à la santé publique et à la gestion du système
2	MOUSSOUNDA MBOUNGOU Beltran	Collaborateur /PNLIR
3	MONKA YOULOU Léger Michel	Responsable suivi évaluation /UCPP
4	POATY MAVOUNGOU Ange	Chef du bureau / PNLIR
5	ETOUMOU Rech	Chef de service de la santé du nouveau-né
6	NGANTSO Arnaud	Chef de département de la documentation , de l'archivage et de la statistique /PNLHV
7	MOUSSAVOU MBONZI Zita	Adjoint du responsable administrative financier comptable /PNLIR
8	LOEMBAMBOU PAMBOU Prisca Nadège	Chef de département de la documentation , de l'archivage et de la statistique /PNLIR
9	MVOUNGOU ONDOUMA Princia	Collaborateur /PNLIR
10	DINGA NGASSESSE Aminata Reine	Collaborateur /PNLIR
11	NGANGA-VICTOIRE Eric	Collaborateur /UCPP
12	MAYELA Jolivet	
13	Mayambi Akangy Stephen Leonard	Chef de service coïnfections tuberculose VIH / PNLS
14	OUALEMBO TENDART Chrislain Van Novique	Collaborateur /PNLIR
15	KOLELA Henriety Evans Fernandel	Collaborateur /PNLIR
16	KISSANGOU-OKAKA Delicia-Raelle	Collaborateur /PNLIR

EQUIPE DE LA VALIDATION

N⁰	Noms et prénoms	Fonction/ Institution
1	MIANGOUMININA Kevin	Adjoint du chef département de la documentation , de l'archivage et de la statistique / UCPP
2	MASSAIA PEYA Jethro	Collaborateur / DELM
3	MOUYOU MAVOUNGOU Rodrigue Serge	Chef de bureau finance ,charge des matériels et la logistique / DISER
4	MAYELA Jolivet	Chef de service recherche / DISER
5	POATY Blaise Guyane	Chef de département de la gestion de la logistique
6	MVOUNGOU ONDOUMA Princia	Collaboratrice /PNLIR
7	MOBOUAKA Stiven	Collaborateur /DEP
8	ETOUNG Gloire Rojudey	Collaborateur
9	AYANDAE Jessica Jeielle	Chef de département prévention et prise en charge/ PNLT
10	MASSAMBA Aimé Rolland	Chef de service des études et planification / DSSSa LEKOUMOU
11	MILINGOU EPENDI Tatiana	Collaboratrice / DEP
12	BOREKO Reine	Secrétaire / UCPP
13	ETITI Fridolin	Responsable administrative financier comptable /PNLIR
14	OKEMOU Dieudonné	Directeur des hôpitaux /DGSSSa
15	MAYELA Jolivet	
16	LOEMBAMBOU PAMBOU Prisca Nadège	Chef de département de la documentation , de l'archivage et de la statistique /PNLIR
17	DINGA NGASSESSE Aminata Reine	Collaboratrice /PNLIR
18	SAMBA Rudy Vivian	Chef de département dépistage et de la surveillance épidémiologique/PNSM
19	ETOUMOU Rech	Chef de service de la santé du nouveau-né

20	NGANTSO Arnaud	Chef de département de la documentation , de l'archivage et de la statistique /PNLHV
21	MOUSSAVOU MBONZI Zita	Adjoint du responsable administrative financier comptable /PNLIR
22	PASSI-LOUAKA Cyr-judi-cael	Responsable des maladies non transmissibles / bureau OMS Congo
23	NDINGA-OKAKA Berline	Médecin généraliste /CHU-B
24	DEBEKA ULRICH	Collaborateur / Laboratoire ROCHE
25	MOUSSOUNDA MBOUNGOU Beltran	Collaborateur /PNLIR
26	MONKA YOULOU Léger Michel	Responsable suivi évaluation /UCPP
27	POATY MAVOUNGOU Ange	Chef du bureau / PNLIR
28	Mayambi Akangy Stephen Leonard	Chef de service coïnfections tuberculose VIH / PNLS